

סיכום סופי

חלק ראשון

פרק ראשון של סמית – ניהול, תכנון ותיאום ההתנסות בשדה הקליני.

שיתוף אקדמי (academic partnership)

- הגדרה – שיתוף פורמלי בין האקדמיה לסביבה הטיפולית במטרה לקדם את המקצוע.
- ערכים – אמון, כבוד, חזון משותף, התמדה, מחויבות, תקשורת המאפשרת שקיפות.
- DEU – גישה שמתבססת על חשיבה מערכתית, היגיון קליני, אחריות ושיתוף פעולה.

מחסומים

- קיצוץ תקציב והיעדר תמיכה כלכלית
- עומס עבודה על סגל הוראה

תוצאות צפויות ממודלים לשיתופי פעולה

- ירידה בהוצאות הבריאות\
- שיפור תוצאות טיפוליות
- שיפור איכות הטיפול ובטיחותו
- מתן הזדמנויות לקידום והתפתחות מקצועית של צוותים.

תוצאות צפויות עבור האקדמיה

- לאפשר מספר משתתפים גדול
- הרחבת הזדמנויות למעורבות במחקר וטיפול מבוסס ראיות
- שיפור במעבר מכיתת הלימוד לשדה הקליני
- הזדמנויות העסקה מרובות
- הוצאות כספיות מופחתות
- שביעות רצון גבוהה של הסטודנטים.

מדריך קליני (clinical preceptor)

הגדרה – אחות שעובדת עם סטודנט במהלך התנסות מוגבלת בזמן בשדה קליני.

תפקידים עיקריים – מודל לחיקוי, לימוד מיומנויות קליניות ופיתוח חשיבה ביקורתית תוך הבטחת מתן טיפול אופטימלי למטופלים.

AACN – קריטריונים

- ניסיון בהדרכה
- שנה של ניסיון קליני
- ידע לגבי הדרישות של תוכנית לימודית
- קשר עם סגל תוכנית ההכשרה
- לדעת ציפיות, דרכים טובות להורות מיומנויות ותחושת מעורבות במקצוע הסיעוד בקרב הסטודנטים.

יתרונות

- עבור הסטודנט – רכישת ידע, אינטגרציה, אוטונומיה, ביטחון, סמכות, סגור על הסטודנט
- מדריך קליני – הרגשת סיפוק והנאה מהעבודה וקידום סטודנטים
- מערכת – סיוע בהתמודדות עם מחסור סגל הוראה, צמצום הוצאות הנדרשות ללימד קליני ופיתוח מיומנויות קליניות
- פיתוח מערכת יחסים שיתופית בין האקדמיה לשירותי הבריאות.

הדרכה קלינית (precepting)

הגדרה – הדגמה, הסברה ושיתוף המציאות של עבודת הסיעוד היומיומית.

מטרה – להראות לסטודנט את מורכבות התפקיד והתמונה הגדולה.

תכונות רצויות של מדריך קליני – אמפתי, מכבד, חוש הומור, הוגן, גמיש, אמין. פיתוח גישה מקצועית באמצעות הכוונה, השגחה והדגמה אישית.

קהל יעד – סטודנטים לסייעות, סטודנטים בתוכנית להכשרה מתקדמת (הדרכה קלינית), אחיות מתחילות.

קריטריונים הכרחיים להדרכה קלינית מוצלחת

- ללמוד איך ללמד אחרים
- מתן משוב
- איזון בין מחויבויות כפולות ללומד והמטופל
- הכנה איכותית ומספקת למדריך הקליני.

חווייה מוצלחת כוללת 3 שלבים – תכנון, ביצוע, הערכה.

- תכנון – להכיר סגנון למידה, להכיר מטופלים והזדמנויות ללימוד מיטבי, קביעת מטרות וסדרי עדיפויות.
- ביצוע – עבודה משותפת של המדריך והלומד. קודם צפייה במדריך ואז ביצוע.
- הערכה – רפלקציה, מתן משוב בונה.

לומדים בסיכון גבוה (high risk students)

הגדרה – יחידים שמקבלים תמיכה סוציאלית, בעלי יכולות קוגניטיביות או משאבים מוגבלים שמגבירים את הסיכוי שלהם לכישלון אקדמי.

סיכון מוגבר בקבוצות מיעוט. חשוב זיהוי מוקדם

משתנים אקדמיים – ציונים

משתנים לא אקדמיים – איכות לימודים בתיכון, מסוגלות עצמית ורמות חרדה ולחץ.

השפעות על קבוצות מיעוט

- סטיגמות
- הפרדה מיתר הלומדים
- פגיעה בביטחון העצמי
- מוטיבציה אקדמית נמוכה
- נטייה מוגברת לכישלון אקדמי.

אסטרטגיות יעילות

- פעילות מונחת אישית
- התאמה בין סגנון למידה של הלומד למדריך
- מתן משוב בונה ומעצב בסביבה תומכת.

תקשורת בין מקצועית (interprofessional communication)

הגדרה – שימוש בשיטות יעילות מילוליות ובלתי מילוליות להשגת שיתוף פעולה מקצועי בין מספר אנשי בריאות לטובת מטופלים ומשפחותיהם.

אסטרטגיות לקידום

- סימולציות – העברת מידע למטופלים בסביבה בטוחה או מלחיצה. כולל דיווח טעויות.
- מטופלים סטנדרטים – הזדמנות למסור מידע רפואי
- שילוב של סטודנטים ממספר תחומי ידע קליני.

חינוך בין מקצועי (interprofessional education)

הגדרה – צורך לפתח שפה והבנה הדדית לשיתוף פעולה בין צוותים.

ארבעת התחומים המרכזיים בחינוך בין מקצועי

- ערכים לחינוך בין מקצועי
- תפקידים-אחריות
- תקשורת בין מקצועית

- צוותים ועבודת צוות.

סיכום הדוחות של FUTURE OF NURSING REPORT

- קידום חינוך בין מקצועי חוצה מקצועות שמגביר שיתוף פעולה ומערכת יחסים לא היררכית
- קידום מקצועיות חדשה המשתמשת בכשירות כקריטריון לדירוג אנשי רפואה
- העצמת סטודנטים למנהיגות ושיתוף פעולה.

הערכת סיכון (risk assessment)

הגדרה – איום פוטנציאלי עבור אחות בכל שלב לימודי על מנת להתקדם ולהצליח או לעבור בהצלחה את מבחן הרישוי.

גורמים המזהמים אצל סטודנטים בסיכון

- אנגלית שאינה שפת אם
- דור ראשון ללימודים אקדמיים
- צורך בחזרה על קורסים בסיסיים
- ציון נמוך מהמוצא
- עבודה
- מחויבויות משפחתיות ללא תמיכה
- חוסר ביטחון עצמי
- קשיי למידה – כתיבה, קריאה, קשב.
- בידוד חברתי
- היעדר תמיכה משפחתית וכלכלית.

RAPSS – כלי המשקלל גורמים מבוססים ראיות המנבאים סיכון.

- קובע אסטרטגיות לשיפור סיכויי ההצלחה של הסטודנטים וניבוי כמות המצליחים
- צמצום פערים כלכליים וחינוכיים
- קידום הכנה לסטודנטים בסיכון
- העלאת מספר האחיות המוסמכות השייכות לרקעים תרבותיים מגוונים או קבוצות מיעוט מקופחות.

סיכון לכישלון (RISK OF FAILURE)

הגדרה – סטודנטים בסיכון לכישלון כאשר אינם משיגים את מטרות הקורס או אינם ממלאים את דרישותיו.

תוצאות רצויות

- הסטודנט נשאר בלימודים
- עומד בדרישות הקורס
- עובר בהצלחה את מבחן הרישוי בעדיפות בניסיון הראשון.
- עומדים בלוחות זמנים של הקורס

תוצאות לא רצויות

- סטודנט עוזב ממניע אישי או חוסר אמון.
- סילוק הסטודנט כתוצאה מכישלון בקורסים
- עיכוב בסיום תוכנית ההכשרה
- חוזר הצלחה בבחינת רישוי.

השלכות כישלון בבחינת רישוי

- אכזבה
- תסכול
- היעדר ביטחון ביכולת להצליח
- תחושה של בזבוז משאבים כלכליים, זמן ואנרגיה.

השלכות עזיבת סטודנטים על תוכנית הכשרה

- כיסאות פנויים
- אובדן דמי שכר לימוד

השלכות כשילון במבחן רישוי על תוכנית הכשרה

- אחוזי הצלחה נמוכים שעשויים להשפיע על מוניטין הקורס
- סטודנטים צעירים או מסורתיים – יכולת מיקוד רבה ללא הסחות דעת.
- סטודנטים לא מסורתיים – מתבססים על ניסיון חיים על מנת להתגבר על מכשולים, מוטיבציה רבה להצליח.
- דרכים להתמודדות – תמיכה של סגל ההוראה

- הבעת התעניינות בסטודנט
- ייעוץ וסיוע בהפעלת משאבי תמיכה
- תמיכה סוציאלית ואקדמית כמו שיעורים פרטיים וקבוצות לימוד.

פרק ראשון של אוקונר – ניהול, תכנון ותיאום ההתנסות בשדה הקליני.

מטרות ההדרכה הקלינית (GOALS OF CLINICAL NURSING EDUCATION):

מטרת על – הכנת המודרך לחשיבה ביקורתית, תקשורת טובה ויישום התערבויות סיעודיות על מנת לטפל במטופלים.

יישום של תיאוריה לקליניקה

הבעיה – פער בין התיאוריה הנלמדת בקמפוסים לשטח הקליני גדול ומעורר חרדה.

פתרון – חשיפה למגוון רחב של סיטואציות לפיתוח מיומנות, עידוד חשיבה ביקורתית שיעזרו לסטודנט לקבל החלטות, זיהוי פתרון בעיות.

פיתוח מיומנויות בתקשורת

תפקיד המדריך

- הנחיית הסטודנט להכיר אסטרגיות תקשורת ולהיות מיומן בשימוש בהן.
- לבנות אצל הסטודנטים מיומנות להקשבה, התבוננות וקבלת האחר.
- יצירת שפה משותפת שמשתמשת במושגים שהמטופל יכול להבין. מילולית או בלתי מילולית.
- התאמת שפה לפי רקע ותרבות המטופל.

אסטרגיות תקשורת

- ראיון
- הדרכת מטופל
- תיעוד תצפיות
- שימוש בטכנולוגיה
- האצלה לגורמים בשירותי הבריאות.

שיחת אחיות (nurse talk)

- מותאמת לסיטואציה קלינית שמשתנה במהרה ולמגבלת הזמן שיש לאחיות במסירת מידע.
- שפה עם הומור שלרוב סטודנטים מרגישים שהיא לא אכפת.
- תפקיד המדריך לשמש כמתורגמן.

שיח חלוקת הוראות (delegation talk)

- אספקט מהטיפול הסיעודי יינתן על ידי אחות אחרת
- אספקט כלפי מעלה – התערבות של רופא.
- צריך להיות ברור לגבי מה הפעולה ומי צריך לבצע.

השפה המקצועית של תחום הבריאות (professional tongue)

- שפה שסטודנטים צריכים ללמוד על מנת לספק תיאור או הסבר מדויק לגבי המצב.
- דוגמה: העברת דיווח לצוות סיעודי בהעברת משמרת.

הדגמת מיומנויות ביישום התערבויות סיעודיות

התקדמות – מיומנויות טכניות שהסטודנט עשה בשטח הקליני.

בעיה – מקור ללחץ עבור סטודנטים

גורמים

- חששות לביצוע טעות
- גרימת נזק
- אי מקצועיות מול מטופל.

תפקיד המדריך

- לקדם פיתוח מיומנויות תוך התייחסות לפרטים קטנים
- הקצאת זמן בצורה הוגנת
- שימוש בשאלות, חזרות ודיונים על טיפולים להעלאת מודעות
- ליצור תחושת ביטחון בקרב הסטודנטים.

שילוב טיפול מבוסס ראיות וממצאי מחקרים בתכנון התערבות סיעודית.

הגדרה – מתן טיפול סיעודי מבוסס על ניתוח ביקורתי של מחקרים ואינטרציה של ראיות חזקות לסיטואציה קלינית.

רוח הסקרנות – מאתגרת הנחות והרגלים, לחפש אחר ראיות שתומכות בעבודת הסיעוד כולל העלאת תובנות חדשות שמשפרות את הטיפול.

- מאפשר שאילת שאלות בהתאם להתערבות סיעודית
- מנחה לשיקול דעת
- מנחה לחקירת מידע מהימן
- מהווה חקירה לגבי תיאום הגישה למטופל ספציפי.

ביסוס התנהגות של דאגה בפעולות סיעודיות

ראיית מנהרה – הסטודנט מתמקד בסיטואציה ולא בתמונה הגדולה.

תפקיד המדריך – להדריך את הסטודנט להבחין בכל היבטי הטיפול ולא בסיטואציה ספציפית.

הצגת כשירות תרבותית בטיפול

מודעות חברתית – בחינה עצמית של הטיות או דעות קדומות והנחות כלפי אחרים.

פיתוח ידע חברתי – הבנת האדם השונה מהסטודנט ואמונותיו.

אומדן פיזיקאלי תרבותי – מחסומים בשפה. יש להתגבר עליהם על מנת לשפר את התקשורת ולהתאים אותה למטופל.

רצון תרבותי – רצון לספק טיפול מותאם תרבות.

ייחודיות במפגשים תרבותיים – על הסטודנט לפתח כשירות תרבותית לאורך כל חייו המקצועיים.

לשקול את התוצאות האתיות הצפויות מהחלטות קליניות שמתקבלות והתערבויות סיעודיות

הגדרה – עשיית הדבר הנכון בסיטואציות בהן יש מספר דרכי פעולה. שיקוף הרצונות והערכים של המטופל תוך אי ביטול שיקול דעתה של האחיות.

בעיות הסטודנט

- אי ראייה של האחר
- התמקדות בביצוע מטלה ולא מצב המטופל
- ללא יכולת להפעיל שיקול דעת שכולל את כל האספקטים של האדם
- נוטים לא לקחת אחריות – ניחושים, הימנעות מלבקש סיוע, רמאות והתעלמות ממצבים בעייתיים.

תפקיד המדריך הקליני

- עידוד יצירת סטנדרט של מוסריות קלינית.
- לאפשר שאילת שאלות, להתייעץ עם צוות טיפולי אחר וחיפוש אחר תשובות.
- מותר לטעות אך לא להסתיר טעויות
- להדריך את הסטודנטים לקחת אחריות על מעשיהם.

פיתוח השקפה לגבי ההקשר הסביבתי בה ניתן הטיפול

מטרה – זיהוי ותגובה לשינויים המהירים בכל מחלקה, למידת סדר עדיפות של כל מחלקה, קצב עבודה ורמת דחיפות.

תפקיד המדריך

- מתן אוריינטציה ותמיכה בסטודנטים – תחושה של חלק מהצוות.
- הצגת סדרי עדיפויות במחלקה ותהליכי התייעוד
- עידוד שאילת שאלות במקום הנחת הנחות
- פיתוח רגישות למציאות הכלכלית במחלקה ומשרד הבריאות.

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומערכות מידע בסביבה הטיפולית

דה פרסונליזציה – קורית בהסתמכות רבה על טכנולוגיה. מצב בו הטיפול ניתן למכונה ולא למטופל.

חוסר עקביות – מונע מהסטודנטים התפתחות של מיומנויות טכנולוגיות ומאתגרת את המדריך הקליני לתכנן אמצעים על מנת להתגבר על מגבלה זו.

תפקיד המדריך

- להכיר לסטודנטים את המנגנון הבסיסי של הטכנולוגיה על מנת להעביר ידע בקלות.
- להכיר לסטודנטים איך עובד הציוד ולמה. מאפשרת גמישות עתידית.

לחוות את מגוון התפקידים של האחות

הגדרה – תפקיד האחיות להיות ראש צוות עבור המטופל ולחלק הוראות בהתאם לכל גורם רפואי והקשר שלו אל המטופל.

מטרות

- מאפשר לסטודנטים לעשות סדר עדיפויות
- מאפשר להם לצפות לתוצאות טיפול מסוימות
- להבין את עיקרון ההמשכיות הטיפול
- לעזור לסטודנט לעקוב אחר התקדמות המטופל.

פיתוח מיומנות הנדרשת לקדם למידה מתמדת.

הגדרה – חינוך בסיעוד צריך להתמקד בבסיס הידע והמיומנויות הרלוונטיות לאוכלוסיות מטופלים ובסביבות הטיפוליות השונות.

צפיות מהסטודנטים

- לבנות ולפתח מומחיות במתן טיפול למטופלים, משפחות וקהילות, ללא קשר למצב הבריאותי, אורח חיים או סביבה טיפולית
- גמישות ביישום הידע והמיומנויות הבסיסיות תוך חיפוש, הערכה ויישום מידע חדש.

פרק שני של אוקונר – סביבה משתנה של הדרכה קלינית.

הסביבה המשתנה של הדרכה קלינית תלויה במספר אספקטים המאפשרים הדרכה מותאמת אישית לסטודנטים:

הטבע של הסטודנט לסיעוד כיום – מאפייני סטודנטים

מסורתיים – נשים לא נשואות, צעירות, בהירות עור.

לא מסורתיים – גיל 25 ומעלה, נוסעים ללימודים, לא לומדים כל השבוע, גברים, קבוצת מיעוט אתני, אנגלית כשפה שנייה, הורים, בעל השכלה או עבודה קודמת.

סטודנטים לסיעוד לא מסורתיים מול המדריך

- **פערים בחינוך בקבוצות מיעוט.** על המדריך לזהות אותם בשלב מוקדם ולהפנות את הסטודנטים הללו לקבל סיוע מהמוסד הלימודי.
- **ניסיון חיים ורקע לימודי.** גישת career ladderling מאפשרת ביצוע תפקידים ברמות נמוכות מאחיות (כוח עזר) שמאפשר למידת הסביבה הקלינית.
- **מרגישים בנוח יותר לאתגר הנחות לעומת סטודנטים מסורתיים.**
- **האתגר הגדול ביותר - פערים בתקשורת** – ערכים, דרכי עבודה והתנהגויות עלולות להיות שונות מציפיות המדריך עקב פער בין דורי (סלנג) או שייכות תרבותית.

סיבות של סטודנטים להחלטה ללמוד סיעוד

- רצון לחולל שינוי בחייהם של אחרים
- רצון ללכת בדרכו של מודל לחיקוי (בן משפחה)
- מפגש טיפולי בעבר (מחלה שלהם או של קרובי משפחה)
- הזדמנות לעבודה
- עלייה בשכר האחיות לאחרונה
- סטטוס חברתי של איש מקצוע עם תואר.

כשירות תרבותית אישית

המדריך הקליני צריך להכיר באמונות שלו, להבין את הרקע התרבותי שלו וכיצד הם משפיעים על התפיסה והתגובה כלפי אחרים. המדריך הקליני צריך לקחת בחשבון את השוני שצפוי לבוא מול הסטודנטים.

עקרונות למידת מבוגרים להעברת למידה בשטח הקליני

- פיתוח עצמאות בלמידה
- הכרה בניסיון חיים קודם כמקור לימוד בעל ערך
- שימוש בגישות חינוכיות המבוססות על צרכים התפתחותיים.
- מתן כבוד למקום של הסטודנט בהווה
- אימוץ גישה המתמקדת בלמידה דרך פתרון בעיות במקום למידה המתמקדת בנושא מסוים.

ההקשר הלימודי של תוכניות לימוד בסיעוד

השוני בין תוכניות הסיעוד כיום מול הסיעוד בעבר

- **תוכנית לימוד גמישה מול חוסר יכולת להשלים את דרישות הקורס.** מעניקה לסטודנטים הזדמנות ללמוד סיעוד למרות מצבם האישי (משפחה, עבודה נוספת).
- **התנסות קלינית במגוון מוסדות (כולל קהילה) לעומת בבית חולים בלבד.** הסטודנטים משובצים במגוון מוסדות רפואיים, דבר שגורם לתחרות על שיבוציהם ומאפשר הרחבה של אפשרויות הקליטה ושיבוץ במשמרות מגוונות. התנסות כזו מאפשרת לפתח ידע אינטלקטואלי, פרקטי ואתי בצורה יעילה.
- **שימוש רב בטכנולוגיה להעברת למידה מול שימוש בדרכים מסורתיות.** החלפת בובות תרגול בבובות חכמות שמאפשרות חוויה המדמה את המציאות, למידה בזום ולא פרונטלית המאפשרת גמישות ואי רכישת ספרים עקב לימוד והערכה בגישה אינטרנטית.
- צריך להיות בקרה על שימוש בטלפון בזמן התנסות – רצוי שיהיו בתיקים.

ההשלכות של החינוך הקליני על מקצוע הסיעוד

- המדריך הקליני צריך לפתח יכולת לספק תקציר של חומר שיעזור לסטודנטים להבין סיטואציה קלינית על מנת שבהמשך הסטודנטים יוכלו לבצע קישורים בהתאם.

- בעת אי זכירה של סטודנט את החומר, המשריך צריך להשתמש בשאלות מכוונות על מנת לסייע לסטודנט לזכור את המידע.
- המעברים התכופים בין סביבות טיפוליות שונות והמזן המוגבל של כל התנסות מוביל לכך שהסטודנטים לרוב מאבדים את הרצף הטיפולי של החולה. תופעה זו מחריפה עקב קיצור ימי אשפוז.
- טכנולוגיה חינוכית – על המדריך להעריך את איכות מקורות המידע שנעשה בהן שימוש והדרך שבה הסטודנט השתמש בהם.

דפוסים של מתן טיפול

התמודדויות האחות עם הסביבה כיום

- השיפור בדרכי הטיפול של מחלות אקוטיות ואוכלוסייה משתנה מובילים לשינוי באופי מקבלי השירות, מקום מתן השירות והשיטות הנעשות לצורך טיפול.
- המשאבים המוגבלים למתן טיפול מובילים לשינויים במאפייני הסביבה הטיפולית.
- יותר קבלה של שוני תרבותי.
- אוכלוסייה מבוגרת יותר
- חולים כרוניים הסובלים ממספר מחלות גורם לטיפול להיות מאתגר עם הפחתת סיכויי הריפוי.
- מקבלי השירות היום הם יותר פרואקטיביים לגבי צורכיהם הרפואיים ובעלי ידע עשיר בתחום (ד"ר גוגל).
- יש צורך בתקשורת עם מלווים תוך הקפדה על שמירת הסודיות הרפואית של המטופל.
- קיצור משך ימי האשפוז עקב פיתוח טכניקות ניתוחיות זעיר פולשניות
- ריבוי מטפלים – גורם למתן טיפול מקוטע אשר מחריף במטופל עם מספר מחלות.

ההשלכות לחינוך קליני בסיעוד

- **מבנה ההתנסות המצומצם** כיום ביחד עם קיצור ימי האשפוז, פוגע ביכולת הסטודנטים לסיעוד לבנות מערכות יחסים, לתרגל מיומנויות תקשורת ולהשיג כשירות תרבותית.
- **אי יכולת לקבל תמונה בורה לגבי מהלך המחלה והרצף שלה עד ההחלמה** – סטודנטים לא מצליחים לנבא סיבוכים אפשריים.
- **יש דגש על תפקיד האחות כמנהלת טיפול** – הסטודנטים צריכים להבין את האחריות של האחות, להעריך את תגובות המטופל וכל שינוי במצבו הדורש התערבות מסוימת.

מערכת הבריאות

ההוצאות של מערכת הבריאות ממשיכות לגדול בעוד שהנגישות לשירותי בריאות מתרחבת. על האחות להיות מודעות לגבי ביטוחי בריאות וההשפעה שלהם על המטופל.

דרכים לריסון ההוצאות הבריאותיות

- הימנעות מבזבז של ציוד רפואי
- תיאום הטיפולים ומניעת כפילויות בטיפול
- תיעוד תגובות המטופל למחלה ולטיפולים
- סגור על המטופלים בתהליך המורכב שהם חווים
- הדרכת מטופלים בשלב מוקדם באשפוז הכוללת את תהליך ההחלמה והסיבוכים האפשריים

הסביבה האקדמית

בסביבה האקדמית חברי הסגל מחליטים לבד על השיעורים ולא משתפים פעולה עם חברי סגל אחרים על מנת להתמודד עם קשיים. ישנה סבילות נמוכה להתחדשות ושינויים.

הפיכה לחלק מצוות סגל ההוראה

- תחילה ראיונות וסינון ראשוני
- חברי סגל עם קביעות – יכולים להגיש לאחר 6 שנים בעבודה. מקבלים מינוי בהתבסס על משוב מחברי סגל אחרים.
- חברי סגל זמניים – חידוש חוזה מידי שנה.

ציפיות מהמדריך הקליני

- **קישור בין התוכן הנלמד בכיתה והתוכן הקליני להשגת יעדים**
 - המדריך הקליני צריך לדעת מה נלמד בכיתה ומתי.
 - הבטחת השגת יעדים – סוגי התנסויות בעבר, ביצועים במסגרתם וידע ומיומנות שנצברו.
- **הערכת תפקוד הסטודנט**
 - מה שיטת הניקוד? עובר מול נכשל, ציונים וכו.
 - מה הסטנדרטים המקובלים לביצוע? באופן עצמאי או עזרה מינמלית.
 - מה מעיד על עמידה ביעדי ההתנסות הקלינית? ציון מול כמות פעולות
 - האם קיימים קריטריונים מסוימים שחייבים על מנת לקבל ציון עובר?
 - מהן ההשלכות של ציון נכשל עבר סטודנט.
 - הערכה חייבת לכלול את תיאור נסיבות האירוע והתנהגות הסטודנט במהלכו.
- **היצמדות לנהלים והליכים מובנים**
 - הכרת לוח החופשים ושעות מערכת הלימוד של הסטודנט
 - וידוא כי הסטודנטים עברו תוכנית חיסונים ובדיקות רפואיות
 - דרישה מהסטודנטים לעבור הכשרה כל שנה בנושא החייה ודפיברילציה עם מכשיר חצי אוטומטי.
- **שמירה על התדמית החיובית של תוכנית הלימודים**
 - גיבוש מערכת יחסים עם העובדים במחלקה על מנת להקל על הסטודנטים.

פיתוח קשרים קולגיאליים עם חברי הסגל – חשוב לתכנן ימי פעילות עם הסגל יחד עם המדריך הקליני על מנת שיוכלו לקחת חלק ביום התנסות.

אוריינטציה לסביבה האקדמית

- גישה למשאבים של המוסד הלימודי – כרטיס זיהוי, אישור חנייה, גישה לספרייה ומשאבים אלקטרוניים.
- אנשים שניתן לפנות אליהם בכדי לקבל עזרה – בדרך כלל מנהל בית ספר וסגנו.
- מבנה הקמפוס – אוריינטציה קצרה על ידי חבר סגל או קבלת מפה של הקמפוס.

הסביבה הקלינית

קריטריונים לבחירת שדה קליני

- מוסד רפואי שעבר אקרדיטציה ומחזיק בפילוסופיה שתואמת את המוסד הלימודי
- סטנדרט גבוה לטיפול ותפקוד האחות
- שדה קליני שיאפשר השגת יעדים לסטודנטים
- שדה קליני בלי דרישות מופרזות – דרישה לתשלום עבור שימוש בשירותי השדה או קבלת מספר סטודנטים מצומצם מאוד.
- אווירה טובה בין צוות המחלקה לסטודנטים – נקבעת על ידי הדרך בה המדריך רואה את צוות המחלקה.

הדרישות להדרכה קלינית

- הבעת דאגה, התייחסות חמה ותקשורת מקרבת של המדריך עם המטופלים – יגרום לשיתוף פעולה מצד המטופלים כאשר יש סטודנטים.
- להבהיר לסטודנטים כי יש יותר מדרך אחת ליישם ושכל אחת מטפלת בגישה אחרת.
- הערכת איש צוות במחלקה והכרה בו כמודל לדוגמה, עוזר לסטודנטים להבין בטפול איכותי.

ציפיות של הצוות המטפל

- רוצים לקבל תמונה כללית לגבי התוכן ויעדי הקורס ולהכיר את הרמה הלימודית של הסטודנטים.
- הסטודנטים ישאלו שאלות על מיקום הציוד ויעדיפו לטפל במטופלים מסוימים.
- הסטודנטים צריכים לקבל גישה לרשומה הרפואית הממוחשבת על מנת לצפות בתוצאות, דיווחים וטיפול תרופתי.
- קיום קשרים חיוביים בין צוות המחלקה לסטודנטים – הסטודנטים יתייעצו עם אנשי צוות ואף יציעו לסייע לצוות המטפל.
- המדריך הקליני יתערב כאשר עולות בעיות הקשורות בביצוע הסטודנטים.

ציפיות הסטודנטים מהמדריך הקליני

- סיוע ביישום תיאורטי במצבים ספציפיים – הנחייה בהסתכלות, הסקת מסקנות, בחירה וביצוע התערבויות והערכתם.
- עצמאית מרבית מול מטופלים
- דוגמה אישית – שיקוף כי הצוות הסיעודי לא אמור לדעת הכל אבל צריך להיות עם ידע ויכולת בלמצוא תשובות מתאימות ללא ניחושים.
- הרגשת נוחות במחלקה – מאפשר ביצוע של הטיפולים הנדרשים באופן מקצועי
- ניהול יעיל של קונפליקטים ולא לקחת חלק בריבים בין הסטודנטים
- סנגור מול צוות המחלקה כאשר יש צורך
- כבוד ואכפתיות
- תיקון במהלך הלמידה בצורה מלמדת ולא משפילה.

צפיות, תקוות וחששות

לא לגרום נזק למטופלים

- הסטודנטים מצפים לעשות טעויות בלמידה אך מתקשים בלקבל זאת כאשר הפגיעה היא במטופל. הכשלים בידע או ביצוע מיומנות נחשבים למצב מסוכן ומעלים חרדה.
- אתגר המדריך – להפוך את הלמידה לבטוחה הן מבחינת הסטודנט ואין מבחינת המטופל.
- תשאול אינטנסיבי עלול לגרום לחוסר אמון בין הסטודנט למדריך ולהעלאת רמת החרדה.
- **תפקיד** - המדריך הקליני צריך לוודא את הידע של הסטודנט, לחזק את הצורך להכנה מתאימה לפני ביצוע מטלה, לסגור פערי ידע, לפתח סביבה של אמון, לאפשר שאילת שאלות חופשית ולהתערב בטעויות שנעשו ללא הלחצה של המטופל או השפלה של הסטודנט.

לעזור למטופלים

- המדריך הקליני צריך לעודד את הסטודנטים לתכנן פעולות טיפוליות על מנת למקסם את יתרונות הטיפול עבור המטופל ולא רק כעבור הלמידה שלהם.
- מוגבלות הזמן ומעמד הסטודנט משפיעים על יכולתו לעזור למטופל ואף מפריעים לרצף הטיפול.
- התסכול שהסטודנט מרגיש כאשר אינו משלים את הטיפול יכול להיות מנותב לשיעור בנושא עבודת צוות ותקשורת להבטחת רצף טיפולי.

אינטגרציה בין ידע לקליניקה

- המדריך הקליני צריך להתייחס לפער בין מה שנלמד בכיתה למה שקורה בשטח.
- המדריך מזהה כשלים באינטגרציה של הסטודנט (פענוח סיטואציה קלינית בצורה שגויה)
- המדריך יעזור לסטודנט להשתמש בתיאוריה הנכונה ולחזק את הדיוק בין התיאוריה לקליניקה.

ללמוד מיומנויות בסיעוד

- הסטודנטים מקשרים את הלמידה עם ביצוע המיומנויות בפעם הראשונה או השגת שליטה ברשימה גדולה של כישורים פסיכומטוריים. מתקשים להסתכל על הסיטואציה הטיפולית הרחבה בשל חוסר נוחות בביצוע הטיפול.
- הגדרה מראש של מספר מיומנויות מצומצם שיבוצעו במהלך ההתנסות, מוריד את הלחץ של הסטודנט לפתח מיומנויות ומונע מזה ששליטה בכישורים טכניים יבוא על חשבון כישורים אחרים בסיעוד.

לפתח תדמית בתור אחות וסטודנט

תדמית חיובית בתור סטודנט	תדמית חיובית בתור אחות
- להצליח לענות נכון על שאלות שנשאלו	- השגת מטרת מתן עזרה למטופלים
- ביצוע המיומנויות ללא פגם	- השגת שליטה באספקטים חדשים בטיפול
- מעורבות בפעולות למידה בכל זמן	- הסיעודי
- שהמדריך הקליני נכח.	- ארגון וסדר
- תשובות נכונות בכל אינטראקציה בין המדריך הקליני והסטודנט.	- תחושת ביטחון וכשירות בביצוע הטיפול.

רגעים של למידה – שאלות של המדריך הקליני את הסטודנטים. יכול להיתפס בתור מבחן וביקורת. בנוסף, הם יעדיפו להיעזר בחבר סטודנט בשביל לא לפגוע בתדמית הסטודנט שלהם.

בנוסף, החשיבה היא קפיצה מהירה מידי לפתרון אחד ויחיד בלי לחפש פתרונות נוספים.

בחירת התנסויות קלינית ללמידה

מטרות התוכנית

- פיתוח שיפוט קליני בעזרת חשיבה ביקורתית תוך שימוש בכישורים לפתרון בעיות וקבלת החלטות.
- פיתוח מיומנויות טכניות
- פיתוח מיומנויות תקשורת עם מטופלים, משפחות ונותני שירות.
- פיתוח התנהגות דואגת
- פיתוח התפקיד הסיעודי המקצועי במלואו בא לידי ביטוי בסגור, תגובה לשינויים ומנהיגות קלינית

- פיתוח היכרות המערכת בה ניתן הטיפול
 - פיתוח אוטונומיה בקבלת החלטות ולקיחת אחריות למעשים.
 - פיתוח היכולת לזהות צרכי למידה ותכנן גישות להשגת צרכים אלה.
- על המדריך לספק התנסויות שיאפשרו לסטודנטים להשיג יעדים שנקבעו בדרך שהוא רוצה להשיג זאת.

הסביבה הלימודית

הסביבה הקלינית משתנה במאפיינים שלה:

- אקוטיות לעומת כרונית
- קצב פעילות המחלקה
- מאפייני המטופלים
- מהלך המחלות השכיחות
- מאפייני הטיפול הסיעודי
- רמת ההתערבות הסיעודית הנדרשת (מניעה, שיקום)
- משך אשפוז
- טכנולוגיה
- גודל הצוות
- רמת האוטונומיה והעצמאות של האחות בקביעת פעולות סיעוד נדרשות
- השלכות של מוגבלות כלכליות על כמות ואיכות הטיפול.

יתרונות החשיפה המגוונת

- הבנת השלכות של אירוע חולי והתהליך הנדרש בכדי להשיג בריאות.
- רכישת שליטה במגוון מיומנויות טכניות הקשורות לצרכים הסיעודיים של המטופל
- הגברת רגישות הסטודנט לדרכים השונות בהן אנשים מגיבים לחולי וטיפול, מאפשר לפתח ידע קליני מיומן ומודעות תפיסית

תפקיד המדריך – לאפשר חוויה לימודית חיובית תוך שיתוף פעולה עם צוות המחלקה ולספק הזדמנויות לסטודנטים לצורך הסתכלות מבלי לדאוג אם כל סטודנט נחשף לאותו מטופל בדיוק.

כישורי המדריך הקליני

- יכולת לנבא את המהלך הצפוי של המטופלים השונים ולמנוע אתגר גדול מידי או שעמום עבור הסטודנטים.
- בעל ביטחון לטפל במגוון בעיות קלינית
- מומחה באבחון ותגובה של צרכי הסטודנטים ללמידה.
- ידע והבנה לגבי תוכנית לימודית – אריזה תוכן והתנסויות היו לפני ההתנסות הנוכחית ומה צפוי להיות אחרי.
- ידע לגבי התוכן התיאורטי הנלמד בקורסים המקבילים להתנסות הקלינית.
- לחבר בין הסטודנט למטופל על מנת לפתח אמון של המטופל ביכולת הסטודנט לטפל בו. התהליך מאפשר פנייה של הסטודנט למדריך ותחושה שיש מומחה מצד המטופל.

מאפייני הלומדים

- על המדריך להיות מודע לרמה האקדמית של כל סטודנט ולרמת הביצועים בהתנסויות קודמות על מנת לקדם כל סטודנט בקצב שלו אל המטרה.
- המדריך הקליני צריך להיזהר ולא להיות מושפע מציונים קודמים
- המדריך מפתח משימות אצל סטודנטים שעוד לא "פרחו" ובוחר מטלה המשכית לסטודנט כמו פיתוח מיומנויות טכניות או יכולת גבוהה לארגן.
- המדריך צריך לקחת בחשבון את מידת הביטחון והחרדה של הסטודנט בבחירת מטלות לימודיות. לאפשר לסטודנט חדר לחוות חוויות חיוביות יותר על מנת להפחית את החרדה
- סטודנט עם עודף ביטחון יהיה מפוקח על מנת למנוע סיכון למטופל
- המדריך הקליני צריך להתשתמש בכישורים הייחודיים של הסטודנט אך להיזהר ממניעת הסטודנט לחשיפה למגוון התנסויות.
- על המדריך לעקוב אחר כישורים פסיכומטריים ולא רק מיומנויות טכניות.
- יש לנסות לכבד במידת האפשר את הבקשות הספציפיות של הסטודנט על מנת לפתח מודעות לצרכים הלימודיים.

- שבירת המבנה המקובע של שיבוץ סטודנט במטופל אחד ולאפשר לו לבעצ מטלה במספר רב של מטופלים על מנת להיחשף למגוון רחב של מצבים.
- פעולות למידה המבוססות טיפול כוללני (HEIMS AND BOYD) -הסטודנט מקבל קווים מנחים שפותחו עבור עקרון מרכזי בהתייחסות לקורס כמו מניעת כאב ומנתח את עקרון זה כפי שבא לידי ביטוי בהתנסות הקלינית.

בחירה של מטלות קליניות

- לאמוד מה קיים בקליניקה
 - נגישות
 - הזדמנויות ללמידה ביחס לחומר התיאורטי ופיתוח מיומנויות
 - התרחשויות שעלולות להפריע ללמידה (שחרור מהיר לדוגמה)
 - האם הצוות המטפל העלה חששות או אזהרות בנוגע למטלות טיפוליות מסוימות.
- מטרות התוכנית והיעדים הנגזרים ממטרות אלו עברו ההתנסות הקלינית.
 - מהו הדגש העיקרי
 - האם הדש מתואר כעיקרון רחב המכיל בתוכו מקרים ספציפיים שמשמים כדוגמאות?
 - מה עוד ניתן ללמוד מהסיטואציה.
 - האם לסטודנט מספיק ידע מקורסים או התנסויות קודמות להתמודד עם סיטואציות.
- מאפייני הסביבה הלימודית הכללית
 - האם ניתן לקשר בין מטלה לבין התנסות קודמת על מנת שיעזור באינטרגציה של חוויה.
 - מסקנות שניתן להסיק מהסביבה הקלינית הספציפית שרלוונטית לסביבות אחרות.
 - שיקולים לגבי הצוות במחלקה שעלולים להשפיע על החוויה הלימודית.
- מה המדריך הקליני מרגיש בנוח לעשות.
 - הציפייה של המדריך לגבי צורך בהשקעת זמן ביחס לסטודנטים מסוימים או מטלות טיפול מסוימות.
 - האם קיים קיפוח בין סטודנטים או שהמטלות עלולות לגרום לסיכון
 - התרחשויות שעלולות להתרחש למטופלים במהלך היום בהתנסות הקלינית וכיצד משפיע על המשך מטלה מתוכננת עבור כל הסטודנטים בקבוצה.
- מאפייני הקבוצה הלימודית ושל הסטודנטים האינדיבידואליים.
 - התנסויות קליניות קודמות
 - רמה ביצועית של כל סטודנט
 - הזדמנות שווה לכל סטודנט להתקדם עבור השגת יעדים אקדמיים.
 - רמת עצמאות של כל סטודנט
 - צרכים ורצונות של הסטודנטים ביחס למטלה ספציפית וסיפוקם
 - רמת הביטחון או החרדה של הסטודנט
 - האם כולם יכולים לפעול בצורה בטיחותית? אם לא איזה אמצעי זהירות לנקוט?
 - צרכים ייחודיים של מטופלים שניתן להתאים לכישורים ייחודיים של הסטודנט.
- תוכניות גיבוי
 - חלוקת סטודנטים לזוגות במהלך ההתנסות בלי לפגוע בהתנסות.
 - האם ניתן לשבץ סטודנט למספר מטופלים
 - התנסויות למידה מחוץ למחלקה שמתייחסות ליעדים הקליניים
 - אופן מיקוד הסטודנטים במערך מיומנויות שמטופל יחיד.
 - האם ניתן להשתמש ולפתח סיפורי מקרה על מנת לנצל בצורה יעילה את עודף הזמן.

שיחת הכנה יומית להתנסות קלינית

מטרה – הכנת הסטודנטים והמדריך הקליני ליום ההתנסות בעזרת מתן הנחיות ספציפיות לציפיות. בונה מודעות בקרב הסטודנטים והבנת רמת המוכנות של כל סטודנט אצל המדריך הקליני.

- העברת משמרת – מספקת מידע לסטודנטים וחושף אותם לסאטגרטיגות תקשורת שלא אחיות להעברת מידע בצורה ברורה ומסודרת. מצד שני, לא מאפשרת להם להשתתף.
- שיחת הכנה לאחר העברת משמרת
- הדרכת הסטודנטים לגשת לאחות בצוות שאחראית על מטופל ששובץ אליה ולקבל ממנה מידע חדש.
- סבב בין הסטודנטים לאחר ששובצו למטופלים ולברר מולם מה התוכניות להיום במקום תשאול שגורם לחרדה, חוסר ביטחון והתנתקות סטודנטים מהשיחה.

הנחייה של למידת סטודנטים בהתנסות קלינית – עקרונות למידה

מוכנות הסטודנטים ללמידה

הגדרה - המוכנות כוללת מוטיבציה ללמידה, שליטה בידע ובמיומנויות קודמות ונוכחות מלאה בחוויה הקלינית מתוך התמקדות בהשגת מטרות הלמידה והמטרות הטיפוליות.

סביבה מגרה – על המדריך הקליני לייצר בסביבה מגרה שמזמינה את הסטודנטים להיות מעורבים בתוכן על מנת להשיג שליטה במיומנויות וזאת על מנת שלא תהיה הסחת דעת מהקשיים האישיים.

- הצבת מטרות ויעדים
- לעורר מודעות של סטודנטים לידע קודם
- לזהות תחומי תוכן שיהיו במרכז המטלה.
- שילוב בין הנטייה להתרכז בצרכי המטופל ליעדי הסטודנט.
- ברור חששות הסטודנטים דרך שאלות פתוחות, שיתוף ראייה של המדריך, הכרה בהצלחות הסטודנט והקשבה בעת שיתוף הסטודנט את החששות שלו.

גיוון בתוכן וטכניקות ההדרכה

- ביצוע שינוי בקצב הלמידה מגייס מחדש את הסטודנטים ומרחיב את הפרספקטיבה שלהם ביחס לתחום מסוים שבו מתבצעת ההתנסות.
- משחקים, סיפורי מקרה, סבב אחיות ודרכים בהם נגשים לתוכן בדרך יצירתית תורמים לגיוון מעורר למידה
- שינוי קטן באוצר המילים או שימוש בתרשים במקום מילים
- חשיפת הסטודנטים לדרכים שונות לביצוע פעולה מאפשר לסטודנט לרכוש שליטה במיומנות.
- חשיפת הסטודנטים לסביבות קליניות אחרות, השתתפות בבדיקות אבחון או ניתוחים.
- הסטודנטים צריכים לחוות את מצבי החולי והטיפול השונים
- הסטודנטים צריכים לחוות גיוון במטלות קליניות שנראות עבורם כמיותרות.

חזרה על תוכן והתנסויות

- שאלות חוזרות של סטודנט מצביעות על עצלנות מחשבתית – יש צורך לגבש תגובה שמזמינה ועוזרת לסטודנט לזכור את המידע.
- עידוד הסטודנטים לסמוך על הזיכרון שלהם ולא להיות תלויים במדריך קליני.
- מתן זרזים – מאפשר לסטודנטים לזהות שהם נתקלו ופתרו בעיות דומות ושיש להם את הידע המספק לעשות זאת שוב.
- חשיפות מרובות למצבים דומים היא שיטה שמחזקת למידה דרך חזרתיות
- הזדמנויות חוזרות לביצוע מיומנות על מנת שהסטודנטים יוכלו לבצע אותה בצורה קלה יותר.

קיום התקת למידה לסיטואציות חדשות

- המדריך הקליני מסייע בהתקת הלמידה על ידי הנחיית הסטודנטים לעבור תחום הידע הרלוונטי על מנת להבין סיטואציה ולאפשר להם לזהות וליישם את הידע.
- שאלות רצף שאלות עשויה להיות מעצבנת למדריך הקליני אך תורמת לסטודנט לבנות מודל לצורך השימוש במאגר הידע שלו.
- הובלת הסטודנט בדרך החשיבה היא שיטה יעילה שמסייעת לסטודנט למצוא את ההיגיון בסיטואציה הקיימת וגיבוש הבנה רחבה המקדמת את הקשר בין פרקטיקה לתיאוריה.

הפיכת הלמידה ללמידה משמעותית

- למידה משמעותית מתבטאת כאשר הסטודנטים מרגישים שהם בדרך להשגת מטרו שנקבעו מראש מהחוויה הלימודית והן מהחוויה הקלינית ויחס למטופל.

- אינטרקציות עם הסטודנטים במהלך יום התנסות מובנית על ידי מטרות בכך שהמדריך מוודא מול הסטודנטים אם יש הרגשה של התקדמות בהשגת המטרות שלהם.

מודל לחיקוי לתפקיד האחות המקצועית

הגדרה – הסטודנטים מחפשים דפוסי ביצועים במהלך ההתנסות הקלינית שמבטאים את תפקיד האחות אליו הם שואפים ולאחר מכן מנסים לחקות אותם.

ככל שהמדריך הקליני שותף פעיל בטיפול הוא צפוי להיות מודל לחיקוי.

מודל החיקוי של WISEMAN

- התנהגויות של ידע טכני – שימוש בציד, ביצוע טיפול, יכולת לדאוג לצורכי המטופל
- התנהגויות של יעילות בין אישית – אינטרקציה עם מטופלים אחרים, חוש הומור, משוב חיובי, משוב בונה להתנהגויות שליליות, אכפתיות.
- התנהגויות של חשיבה ביקורתית – מקשיב בהעברת משמרת, שואל שאלות.
- התנהגויות של תפקיד מקצועי – מציג את עצמו למטופלים, שומר על סודיות, מכבד, מעודד שיח על דילמות אתיות, גישה נלהבת.

ניהול של התנסויות מחוץ למחלקה

הגדרה – התנסויות שעוזרות לסטודנט לבצע אינטגרציה בין המרכיבים השונים הקשורים בתהליך שהמטופל עובר ותקשור בביטחון מול המטופלים לגבי תהליך ומהלך ההחלמה הצפוי.

- התנסויות אלה יכולות להיות בקשר הדוק עם המחלקה (כירורגיה וחדרי ניתוח) או חוויות שפחות קשורות למחלקה המסוימת.
- לרוב אינן בשליטת המדריך הקליני.
- על המדריך לפתח יעדים ספציפיים ולתת הנחיות ומטלות ביחס להתנסות ככלי שמעיד על השגת יעדים אלו.
 - איפה ומתי ההתנסות
 - מי איש הקשר והמנחה
 - מה הם צפויים לראות
 - מה התפקיד המצופה מהם במסגרת התנסות זו.
- **דיווח** – עדיפות להצגה בעל פה מול הקבוצה על מנת שהמדריך הקליני יוכל לוודא את השתתפות הסטודנט בפעילות שתוכננה והשגת היעדים שנקבעו להתנסות מחוץ למחלקה.
- הדגשת החיבור בין ההתנסות מחוץ למחלקה למחלקה עצמה מעודדת את הסטודנטים להשתתף בהתנסויות ולהעריך את הידע שניתן להשיג דרך הסתכלות או אינטראקציות פשוטות.

ניצול הזדמנויות

- חוויה בלתי רגילה או אירוע עם הזדמנות ללמידה מאפשר למדריך הקליני להרגיש חופשי לנצל את ההזדמנות מבלי לדאוג כיצד חוויה זו מתאימה ליעדים שתוכננו ליום הקליני או ליעדים הכלליים.
- המדריך הקליני צריך להיות ערני לאירועים אלה המאפשרים להעמיק את הלמידה וההבנה לגבי אספקטים של תפקיד האחות.
- גישה לניצול הזדמנויות – לקחת בחשבון קווים מנחים. לרוב הם נגזרים מהמסגרת הרעיונית של תוכנית הלימודים וכוללת עקרונות של תקשורת, התפתחות, אובדן, אוטונומיה, כבוד המטופל ונחמה.

דיון סוף יום התנסות

מטרות

- מתן זמן לסטודנטים ולמדריך הקליני לבצע רפלקציה על אירועי היום, המשמעות שלהם ולקשר אותם למה שנלמד בכיתה.
- תרומה להשגת יעדי ההתנסות
- בחינת הדומה והשונה בתגובות המטופלים במצבי חולי וטיפולים ייחודיים.
- שיתוף בחוויות – הרחבת חשיפת הסטודנטים להתרחשויות.
- קידום למידה המאפשרת לסטודנט להביע את הרגשות והגישות כלפי החוויות שלהם.
- חשיפת הסטודנטים לשימוש היעיל של התהליך הקבוצתי.
- שותפות בין הסטודנטים למדריך.

קשיים נפוצים בדיון סוף יום שעלולים למנוע מהסטודנטים להשיג מטרות אלה

- מדריך קליני משתלט – שימוש לצורך הערכת הלמידה במקום הזדמנות לקדם למידה.
- מדריך קליני שמשתמש בדיון לצורך לימוד שלא נלמד בכיתה
- דיון שמבוצע לפי תור ולא כדיון קבוצתי – התנתקות סטודנטים מהסיטואציה עד הגעה לתור שלהם.
- תוכן ושאלות ברמה קוגניטיבית נמוכה – דיון חסר ערך ומשעמם.
- רמות אנרגיה נמוכות מצד המדריך הקליני או הסטודנטים – יש לחשוב על דרכים חדשניות ומעוררות להעברת הנושאים ולשמור על דיון לוחט.

תוכן הדיון

- אירועים משמעותיים שהתרחשו במהלך היום
- יעד קליני
- חוויות דומות של סטודנטים.
- שאלות פתוחות ולא מאיימות שדורשות מהסטודנטים לשתף בחוויה או הסתכלות.
- אווירה שמגרה לשאלות וחשיבה.

דרכים לקידום של דיון בסוף יום התנסות

- לתמוך בשיתוף ידע
- לשמור על התקדמות הדיון באופן משמעותי תוך גמישות ופתיחות לדכי למידה חלופיות
- לעודד מעורבות פעילה של כל הסטודנטים בעזרת שאילת שאלות, מתן רמזים, העלאת רעיונות.
- לספק משוב לא מאיים
- לעזור לסטודנטים לזהות קשרים, דפוסים ומגמות בחוויות
- לקדם תהליך קבוצתי בעזרת מתן עידוד לכל סטודנט שהשתתף.

פרק שני של סמית – תיווך ערכי, ליבת המקצוע, עקרונות חוקים ונהלים רלוונטים.

חוסר יושרה אקדמית (Academic Dishonesty)

הגדרה – סטודנט שמקבל או מגיש עזרה ללא אישור או קבלת קרדיט עבור עבודה שלא בוצעו על ידו.

ערכים חשובים ביושרה אקדמית – כבוד, אמון, הגינות, להעריך, לקיחת אחריות.

סוגי חוסר יושרה אקדמית

- העתקה – שימוש במילים או רעיון של אדם אחר ללא מתן הכרה למקור
- המצאה – אינפורמציה ללא ביסוס
- זיוף – מניפולציה של נתונים ודיווח לא נכון
- ייצוג לא הגון – התחזות, קניית עבודות.
- רמאות – ניסיון להשתמש בידע או שיטות ללא הרשאה.

השפעות חוסר יושרה אקדמית

- פגיעה בשם הטוב של מוסד הלימודים
- הענקת יתרון לא הוגן לסטודנטים לא אמינים
- רמאות חוזרת
- פגיעה עקיפה בסטודנטים הוגנים
- השפעות הרסניות על תוצאות הטיפול בקליניקה.

תקשורת פרואקטיבית – המפתח למניעה והתעמתות עם התנהגות לא ישרה. כוללת:

- נהלים
- אחריות
- פעולה מתמשכת
- אחריותיות
- מחויבות
- אמון
- יוזמה
- ערכים
- ציפיות.

כישלון אקדמי (academic failure)

הגדרה – עזיבה לא רצונית של סטודנט בעקבות סיבה אקדמית.

גורמים אישיים

- מחויבות כלכלית ומשפחתית
- אי לקיחת אחריות
- קשיים בשפה.

גורמים אקדמיים

- תפיסה לא ריאלית לגבי הקשיים בלימודים
- הכנה לא מספקת והלם במעבר למקצוע הסיעוד.

גורמים סביבתיים

- סביבה לא מתאימה ללימודים
- היעדר לימוד אישי או משאבים מוסדיים תומכים בקשיי למידה.

גורמי סיכון – חשוב!

- גיל מבוגר
- סיעוד כתואר שני (מסלול הסבה)

- מחויבויות משפחתיות גדולות (ילדים)
- קשיי שפה
- דור ראשון ללימודים אקדמיים.

השלכות

- השלכות פסיכולוגיות וכלכליות עם השפעה לכל החיים על הסטודנט
- השלכות כלכליות עקב משאבים כלכליים מוגבלים ומחסור בסגל הוראה מצד המוסד הלימודי
- החרפת המחסור באחיות.

יושרה אקדמית (academic integrity)

הגדרה – מחויבות לשש ערכי ליבה: כנות, אמון, הוגנות, כבוד, אחריות ואומץ לתמוך ולפעול על פי יושרה אקדמית בלמידה ומחקר.

טכנולוגיה – נגישות קלה לחומרים באינטרנט יכולה להשפיע על תפיסות הסטודנטים וסגל ההוראה בקשר לחוסר יושרה אקדמית – לנרמל אותם. יש לקבוע נהלים על מנת שזה לא יקרה.

תפקיד המחנך בסיעוד – להיות מודל לחיקוי בתחום היושרה האקדמית ובתחום המקצועיות בהתאם לסטנדרט של יושרה אקדמית הן בכיתה והן בשטח – קידום כנות ויושרה.

מנהיגות אקדמית (academic leadership)

הגדרה – תהליך שעוזר לאנשים לזהות, לעמת ולפתור בעיות שדורשות הסתגלות למצבים שונים בהם אין פתרון או התנהגות נכונה שגרתית. הנכונות להתאים או לשנות ערכים ואמונות בסביבה אקדמית.

אתגרים

- ריבוי תפקידים
- פיתוח מנהיגות. תוכניות פורמליות הן סלקטיביות. יש להשתמש בחונכות לא פורמלית ופיתוח מנהיגות פנימי.
- היעדר תוכניות להמשכיות.
- פעולה של רבים- צריך לשתף את כל חברי הארגון.

התנהגות אקדמית בלתי הולמת (academic misconduct)

הגדרה – עבודה אקדמית המבוצעת באופן שקרי ומודע בכיתת הלימוד או בשטח.

התנהגות בלתי הולמת בלימודים האקדמיים

- שיתוף פעולה עם אחרים בביצוע מטלה אישית (הכי הרבה)
- העתקה ממקורות מידע אינטרנטיים או סטודנטים אחרים בלי התייחסות למקור
- השגת תשובות לבחינה מאדם שנבחן לפני
- שימוש בתירוץ שקרי או המצאה על מנת לדחות מועד הגשת מבחן או מטלה
- הגשת עבודה כתובה מועתקת
- קניית עבודה

התנהגות בלתי הולמת במסגרת הקלינית

- הפרת חובת הסודיות הרפואית – שיתוף צוותים על מטופלים מחוץ למסגרת השטח הקליני.
- דיווח על סימנים חיוניים שלא בוצעו בפועל
- דיווח על טיפול שלא ניתן או שלא ראו.
- דיווח על תגובת המטופל מבלי לבצע הערכה.
- דיווח על תרופות שלא ניתנו
- חוסר דיווח על טעויות
- חוסר עימות עם מטפל לגבי רישום טיפול שגוי.

אסטרטגיות לצמצום התנהגות אקדמית בלתי הולמת

- מבחני יושרה
- הרחקת כיסאות בזמן בחינה
- דרישה מהסטודנטים להשאיר חפצים אישיים בקדמת הכיתה

- הימצאות שני משגיחים בזמן בחינה.
- הגבלת זמן הבחינה
- אי יציאה מהכיתה בזמן מבחן
- הצגת סיבה מוצדקת במידה והסטודנט נעדר מהמבחן.
- שימוש בתוכנות לזיהוי העתקות.

בריונות (bullying)

הגדרה – פעולות חוזרות לא מוצדקות שמבוצעות במטרה להפחיד, לערער או להשפיל. לרוב מתרחשות בפערי כוח (אחיות ותיקות מול חדשות, מדריך מול סטודנטים).

בריונות מוחצנת – צעקות, אימים, הקטנה, השפלה, הפצת שמועות או ריכול

בריונות סמויה – קשה יותר להוכחה וכוללת בידוד חברתי, שינוי ציפיות או מועדי הגשה, מתן מידע במטרה להכשיל.

HORIZONTAL VIOLENCE – בריונות של צוות כלפי צוות אחר כתוצאה ממעמד היררכי.

ההתנהגות הבריונית השכיחה ביותר – מאמצי הסטודנט אינם מוערכים כצפוי. והשני קבלת ביקורת לא הוגנת.

המלצות

- הבטחת מימונויות תקשורת ומימונויות לפתרון קונפליקטים בקרב סטודנטים לסיעוד
- סטודנטים יהיו מוכנים לתמוך בחבריהם במידה ויתקלו בבריונות
- האחיות יתנו ביקורת בונה לסטודנטים

דאגה (caring)

הגדרה – רעיון מוסרי שבא לידי ביטוי דרך תהליכים של עשיית טוב (אהבה, טוב לב, כבוד, אמון, הקשבה, קבלת החלטות יצירתיות, גישה פתוחה לחוסר ידע). דאגה היא מהות הסיעוד.

אסטרטגיות ללימודי תיאוריות לדאגה

- סיפורי מקרה
- שיקוף
- סיטואציות של דאגה
- אומדן קליני מובנה אובייקטיבי
- משחקי תפקידים.

אדיבות (civility)

הגדרה – התנהגות שבאה לידי ביטוי במפגש בין שני אנשים שיש ביניהם קונפליקט. התנהגות מנומסת, הוגנת ומכבדת את נקודת המבט של האחר. יש צורך להביע נכונות להקשיב לדעה סותרת.

חוסר אדיבות – התנהגות בוטה שלרוב גורמת למצוקה גופנית או נפשית ומהווה מחסום ללמידה ואף עשויה להוביל לאלימות.

- ככל שרמת הסטרס עולה בקרב הסטודנטים או סגל ההוראה, כך האינטרקציות האדיבות פוחתות.

חוסר אדיבות מצד סטודנטים

- איחורים או יציאה מהכיתה לפני סיום השיעור
- הערות לא מנומסות
- פטפט בזמן שיעור
- שימוש בטכנולוגיות שלא לצורך השיעור.

חוסר אדיבות מצד סגל ההוראה

- חוסר הוגנות
- נוקשות וחוסר גמישות
- אפליה

אסטרטגיות לקידום מודעות ושימוש באדיבות

- פיתוח נהלים להתמודדות עם חוסר אדיבות
- יצירת ציפיות לתרבות ההתנהגות בכיתה
- תקשורת מתחשבת בצורכי הסטודנטים וסגל ההוראה

- יצירת הזדמנויות לשיפור תקשורת

רמאות בקרב סטודנטים (student cheating)

הגדרה – עבירה על החוק או על כלל במטרה להשגת יתרון במשהו או בכדי להתחמק מעונש דרך הונאה או הולכת שולל.

גורמים שמחריפים את חוסר ההגינות

- התפתחות הטכנולוגיה
- תחרות בסיעוד

סוגי רמאות

- שיתוף פעולה אסור
- שימוש במשאבים אסורים
- גניבה ספרותית
- זיוף מסמכים
- פגיעה בטוהר הבחינה – העתקה.

דרכי התמודדות

- סגל ההוראה יאמץ בשנית את האסטרטגיות בזמן שימוש בטכנולוגיה והחשש מרמאות.
- מטלות כתובות צריכות להכיל אינטגרציה של מידע שאינו נגיש באינטרנט
- פיתוח פעילויות אינטראקטיביות שמייצגים את הידע של הסטודנט

התנהגות מפריעה (disruptive behavior)

הגדרה – כל התנהגות בלתי הולמת, עימות או קונפליקט. התנהגות שמאיימת על בטיחות המטופלים וביכולת עובדי הבריאות לבצע את עבודתם באופן ראוי.

דוגמאות – דיבור לא מכבד, הערות מיניות, הרמת קול, בדיחות גזעניות, העברת ביקורת חדה.

ארבע כלים להפחתת התנהגות מפריעה

1. **תוכניות התמחות ואוריינטציה מחלקתית** – מספקות הדרכה קלינית חיובית לקידום תרבות מקצועית. מלמדות את עובדי הבריאות לעבוד בצורה יעילה בתוך צוות רב מקצועי תוך שיתוף פעולה בקבלת החלטות וכבוד הדדי.
2. **שיתוף פעולה בין המסלול האקדמי לקליניקה** – שיפור המקצועיות, התקשורת ודרך מתן טיפול רפואי מיטבי.
3. **אפס סובלנות להתנהגות שפוגעת או מסכנת את הביטחון**
4. **התייחסות להתנהגות שלילית** – זיהוי, שיקוף ההתנהגות, לקיחת חלק ביוזמה למניעת אלימות ווידוא כי ערכי המקום משקפים את הקוד האתי.

הפחתת היארעות על פי DELLASEGA

- חינוך אחיות שהן קורבנות להתנהגות מפריעה לגבי ההתנהגות במטרה לשפר מודעות
- לימוד אסטרטגיות תקשורתיות בכדי לעזור לאחיות להתחבר
- שימוש במודל לחיקוי בכדי לבצע אינטגרציה של התנהגות מתאימה.

תיקון בשדה הקליני (clinical remediation)

הגדרה – תהליך של תיקון חסרים או ליקויים בעבודת הסיעוד וקידום טיפול בטיחותי והוצאה לפועל של אסטרטגיות לשיפור חשיבה קריטית ותפקוד.

- תהליך מותאם אישית תוך תמיכה, ייעוץ ופיתוח מיומנויות. מכיל בתוכו אובייקטיביות, פתיחות ושקיפות.

מטרה – לשמור על בטיחות המטופל, עמידה בסטנדרטים טיפוליים ופיתוח מקצועי.

פעילויות התומכות בתהליכי התיקון

- סימולציה – שימוש בסימולטורים ומטופלים מדומים לאוכלוסיית מטופלים מוגדרת.
- סיפורי מקרה – למידה על ידי חזרות עם מתן משוב מיידי, זיהוי החולשות והחוזקות של הפרט.
- שילוב משאבים תיאורטיים ומחקריים – ביסוס מחקרי המספק משוב.

מחסומים לתיקון

- שימוש לא מספק או חוסר שימוש בתיאוריה בפיתוח התערבויות
- עיכוב בהוצאה לפועל של התוכנית

- סטרוס וחרדה.

מודעות תרבותית (cultural awareness)

הגדרה – תהליך של בחינת השפעות של רגשות ומחשבות על העצמי במפגשים עם האחר. ישנו צורך להבין תרבויות שונות על מנת להימנע מכפייה תרבותית ואתנוצנטריזם (התרבות שלי טובה יותר). מהווה מרכיב עיקרי בתהליך השגת הכשירות התרבותית.

המאפיינים העיקריים – מין, דת, גיל ולאום

המאפיינים השניוניים – השכלה, עיסוק ומעמד סוציו אקונומי.

כשירות תרבותית (cultural competency)

הגדרה – מערכת של התנהגויות, גישות ונהלים חוצי תרבות שמאפשרים עבודה יעילה במצבים שונים. מאפשרת לסטודנט לקחת אנמנזה שלוקחת בחשבון את התרבות של האדם. יש להיחשף למספר רב של תרבויות על מנת לפתח כשירות תרבותית.

שונות תרבותית (cultural diversity)

הגדרות – תלויות בקונטקסט

- בקונטקסט של ייצוג – שימוש בשונות התרבותית על מנת לייצג תמונה של קבוצות סוציאליות שלרוב מוגדרות לפי גזע, מין, גיל או מעמד סוציאקונומי
- בקונטקסט של אידיאולוגיה – מתייחס למערך של אמונות במטרה לשנות דעה של אנשים אחרים.

תהליכים המקדמים מודעות וכשירות תרבותית

- מפגשים וירטואליים עם מטופלים מגוונים – מאפשר תרגול ידע תרבותי בסביבה בטוחה
- הרצאה על ידי גורם חיצוני
- השתתפות באירועים רשמיים העוסקים בענייני שונות תרבותית.
- לימודים בחו"ל וחוויות בתוך תרבויות שונות – מעודדים רגישות תרבותית והפחתת סטריאוטיפים.

3 נקודות מפתח בהבנת שונות תרבותית

- ארגונים מקצועיים מעריכים ותומכים שונות תרבותית – עידוד שונות גזעית, קידום ערכים של כבוד וקבלה.
- למרות קידום השונות עדיין רוב האחיות לבנות – חוסר התאמה בין ערכי המקצוע לבין תוצאות הטיפול. יש לקדם שונות במקצוע ובלימודי הסיעוד.
- מחנכים בסיעוד צריכים לקדם סטודנטים להשגת כשירות ורגישות תרבותי בכדי שיהיה כשירים לטיפול מותאם תרבותית.

ביטחון תרבותי (cultural safety)

הגדרה – המודעות והפעולות המכוונות להבטחת תחושת ביטחון בקרב מטופלים מרקעים שונים במפגשים טיפוליים.

מטרה – להגן על זהותו של המטופל (במיוחד קבוצות מיעוט) ולקחת בחשבון את יחסי הכוח שעשויים להשפיע על הבריאות.

תפקיד המחנכים בסיעוד

- לזהות תפיסות מודעות ובלתי מודעות של אחרים ולהבין כיצד משפיעות על מערכת היחסים במפגש הטיפול.
- קידום סביבה לימודית בטוחה ומכילה בה כל אחד יכול לשקף או להביע את זהותו התרבותית
- עידוד הסטודנטים לשקף לעצמם את הגישה ויחסי הכוח כלפי המטופלים ולא להתמקד במנהגים תרבותיים.
- קידום אחות שחוקרת את הדרכים בהם המטופל עשוי להרגיש מאויים במפגש הטיפול.

יושרה (moral integrity)

הגדרה – לדעת להפריד בין טוב לרע, לדבר על מה שהאדם יודע שהוא נכון ולפעול על פי ידיעה זו אפילו במחיר אישי בצורה עקבית עד כמה שניתן. יושרה מהווה תדמית אמינה, עמידה למניעים ואינה נטולה בספק. כעס או אשמה יכולים לבוא לידי ביטוי בחוסר יושרה שגורמים בסופו של דבר לשחיקה.

תפקיד המדריך – להדריך את הסטודנט על יושרה מהלימודים האקדמאיים. להתאים את מאפייני הכיתה ותכני הלימוד על מנת להטמיע ערכים ויושרה.

בטיחות המטופלים (patient safety)

הגדרה – מרכיב מחייב של שירות בריאות איכותי. כולל קידום ושימור הבריאות הפיזית, הפסיכולוגית, הסוציאלית, התרבותית והרוחנית.

הגדרות של אסטרטגיות לפיתוח ידע וגישות בתחום בטיחות המטופלים

- מכילות את התפקידים של האחיות.
- ידע מבוסס ראיות
- טיפול ממוקד במטופל
- הגיון קליני
- תקשורת בתוך הצוות
- תיאוריות מערכתיות
- זיהוי סיכונים
- ניהול והבראה.

סוגי אסטרטגיות

- הפעלות של קבוצות קטנות
- סיפורי מקרה
- העברת הרצאות אינטראקטיביות
- סימולציות – מאפשר לקדם את הכישורים בבטיחות בסביבה בעלת סיכון נמוך.

תפקיד המחנכים בסיעוד

- לעסוק בלמידה שתאפשר לבצע חשיבה ביקורתית כלפי הטיפול והמערכת.
- לעודד למידה של בטיחות מטופלים
- לזהות מצבים שעלולים לסכן את בטיחות הטיפול.
- להעריך את תהליך את הרכישה וההוצאה לפועל של כישורים בתחום הבטיחות.
- ללמוד מטעויות ולהימנע מהם ולא לחפש אשמים או מתן עונש עקב טעות.

איכות ובטיחות (quality and safety - QSEN)

הגדרה – תוצאות הכרחיות של הטיפול הסיעודי.

6 מיומנויות

- טיפול ממוקד במטופל
- עבודת צוות ושיתוף פעולה
- בטיחות
- שיפור איכות
- אינפורמטיקה וטיפול מבוסס ראיות
- משאבים לשיפור חינוך עכשווי בהקשר של איכות ובטיחות.

מטרה – להבטיח שכל אחת תהיה מיומנת על מנת לשפר באופן מתמיד את איכות ובטיחות של מערכות בריאות.

החלטות אתיות (ethical decision making)

הגדרה – תהליך מורכב ודינמי בו בעיה מוסרית נחקרת דרך פרספקטיבות שונות עד להשגת פתרון.

הרקע התרבותי, הסביבה הארגונית, הנסיון המקצועי והידע האתי מהווים תפקיד מפתח בקבלת החלטות אתיות.

מודל לקבלת החלטות אתיות

- זיהוי בעיה
- איסוף מידע להבנת המצב
- חיפוש אחר פתרונות אפשריים
- הוצאה לפועל של הפתרון הנבחר
- הערכה של התוצאות.

גורמים למוכנות נמוכה של סטודנטים בהתמודדות עם דילמות אתיות

- התמקדות תוכנית ההכשרה במיומנות טכנית על מנת לעבור את מבחן הרישוי ולא מעבר
- חוסר זמן לפתח מיומנויות של סטודנטים בקרב סגל ההוראה עקב יד חופשית בנושא זה.
- חוסר בהנחיות ברורות לגבי ההכשרה הנדרשת לסגל ההוראה במטרה ללמד אתיקה.

חוקים

חוק למניעת הטרדה מינית

מטרת החוק – לאסור הטרדה מינית בכדי להגן על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו ולקדם שוויון בין המינים.

מעשים הנחשבים הטרדה מינית

- סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשות בעל אופי מיני.
- מעשים מגונים (חשיפת איבר מין, נגיעות, התחככות)
- הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (הצעה למתן יחס מועדף בתמורה לטובת הנאה מינית)
- התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני
- התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו ומיניותו של האדם (כינוי בשמות, הצגת תמונות פורנוגרפיות)
- פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו בצורה שעלולה להשפילו וללא הסכמתו.
- יחסי מרות – בין עובד למעביד. נחשב הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה אי הסכמה.
- התנכלות – פגיעה שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או תביעה שהוגשו על הטרדה מינית.

עונשים על הטרדה מינית והתנכלות

- מטריד מינית דינו מאסר שנתיים
- מתנכל דינו 3 שנים מאסר
- מטריד ומתנכל 4 שנים מאסר.

נקיטת אמצעים בידי המעביד למניעת הטרדה מינית

- לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה של הטרדה מינית והתנכלות ולבירור התלונה.
- לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית
- למנוע ככל האפשר את הישנות המעשים.
- מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים מחויב לקבוע ולפרסם תקנון בו יובא החוק ויפורטו דרכי הגשת התלונות והטיפול בהן. אי פרסום תקנון – קנס. קנס נוסף לכל שבוע בו נמשכה העבירה.

חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים

אזהרה על ידי מנהל מוסד רפואי – אם אדם נקט באלימות פיזית או מילולית כלפי הצוות או השחית במתכוון רכוש של מוסד, רשאי מנהל המוסד להזהיר בכתב כי אם בתקופה של שנה יבצע זאת שוב, לא יוכל להיכנס למוסד.

הוראה בדבר מניעת כניסה למוסד

- האדם לא עמד בתנאי שלא לפעול באלימות במשך שנה, ניתן להורות לו לא להיכנס למוסד או לחלקים ממנו.
- אם נקט אלימות פיזית – ההרחקה לא תעלה על 6 חודשים
- אם נקט באלימות מילולית או השחית רכוש – ההרחקה לא תעלה על 3 חודשים.

דרישת הזדהות – מנהל המוסד רשאי לדרוש מאדם המתנהל באלימות למסור את שמו ומענו ולהציג תעודת זהות. זאת על מנת לנקוט באמצעים למעלה.

הקוד האתי של אחים ואחיות בישראל

מטרה – מצפן לעוסקים בסיעוד במצבים של דילמות או קונפליקטים אתיים ומקצועיים. כאשר נדרשת הכרעה יש להתבסס על הקוד האתי.

חובות וזכויות לפי הקוד האתי

ערך / עקרון	זכות המטופלים	חובת המטופלים
כבוד האדם וחירותו	- קבלת טיפול ללא אפליה או משוא פנים - מענה על צרכים בריאותיים, רגשיים, רוחניים ותרבותיים. - קבלת טיפול תוך התייחסות לשייכות למסגרות חברתיות - למות בכבוד תוך שמירה על ערכים ועצמאות.	- הבטחת שמירת זכויות האדם ללא הבדל גזע, דת, לאום, מין, מגדר, השתייכות פוליטית, מעמד חברתי או מצב בריאותי. - התייחסות לצרכי המטופל ומשפחתו. - הכרה בשייכות האדם למסגרות חברתיות שונות - לשמור על נוחותו לשחרר מהסבל, מחרדה ומכאב ולהקל עליו ככל האפשר. - לאפשר לאדם הנוטה למות לממש את מירב משאלותיו ולסייע למשפחתו להתמודד עם האובדן.
אוטונומיה הסכמה מדעת	- קבלת מידע רפואי לרבות סיכונים, סיכויים וחלופות טיפול.	- מסירת מידע למטופל בהתחשב ברצונו ויכולתו לקבל את ההסבר ולהבין אותו. - להבטיח שהעברת מידע למשפחה תתבצע לאחר שהסכים לכך. - לספק למטופל מידע שבאמצעותו יוכל להבין את דרכי הטיפול ולהחליט עליהם.
בחירה חופשית	- להסכים או לסרב לקבל טיפול / להשתתף בניסוי	- לבדוק את המניעים לסירובו, לספק מידע לגבי התוצאות הרצויות, לבדוק חלופות לטיפול, להסביר ולכבד את החלטתו - לספק מידע הקשור בעריכת הניסוי ולכבד החלטתו של המטופל.
חופש בקבלת החלטות	- לקבל החלטות הקשורות בטיפול בו	- שיתוף המטופל בהחלטות הקשורות בטיפולו תוך הכרה בסמכותו ובזכותו לקבל הכרעות.
עצמאות ואחריות	- לקבל החלטות הקשורות בטיפול בו	- ליזום פעולות שיביאו את המטופל להשתתף באחריות לטיפול. - לעודד את המטופל לקבל רמה סבירה של עצמאות.
פרטיות וצנעת הפרט	- לקבל טיפול תוך שמירה על כבודו וצנעתו - שמירה על סודיות בכל הנוגע למצבו, אבחון או הטיפול בו	- שמירה על פרטיות וצנעת המטופל. - שמירה על סודיות וחסיון מידע. - להימנע ממסירת מידע לגורמים שלא בצוות המטפל. - להימנע משיחות על מטופלים מחוץ למסגרת הטיפולית
איכות ובטיחות	- קבלת טיפול מקצועי, מיומן ובטוח	- טיפול מיומן ובטוח מתוך אחריות ומחויבות - שיפור כישורים מקצועיים הן ברגיעה והן בחירום - להיות שותפים אבטחת איכות טיפול וקביעת תקני עשייה, בקרה ושיפור.
אמון	- קבלת טיפול המושתת על אמון	- לייצר יחסי אמון בין המטופל למטפל
בריאות החברה	- זכות לבריאות מירבית	- לפעול לקידום בריאות של החברה.
העצמת מטופלים	- לקבוע הליכים וקדימויות בהחלטות הנוגעות לבריאות בקהילה	- ליזום פעילויות להעצמת הפרט והקהילה ולייצג עמדות וצרכים של הקהילה.
צדק חברתי וייצוג	- זכות לייצוג הולם	- לתת ייצוג לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בהעלאת בעיותיהם ולדין ודיבור בשמם כאשר אינם מסוגלים לכך
בריאות הסביבה	- הזכות לחיים בסביבה אקולוגית בריאה	- שימור איכות הסביבה - לקחת חלק בוועדות שיש להם קשר למדיניות בתחום הבריאות והשפעה על עיצובה. - ליידיע את הציבור בנוגע לזכויותיו מתוך ניצול התקשורת.

קוד אתי בהקשר של אחים ואחיות ועמיתיהם למקצוע הסייעוד ומקצועות אחרים.

ערך / עקרון	זכות האחיות והאחים	חובת ההנהגה המקצועית
כבוד העובד	- לפעול במסגרת סביבה שמכבדת את העובד ומאפשרת משאבים למתן טיפול איכותי.	- להכיר ולהבין את הערכים והאמונות של ציבור האחיות והאחים, לכבד ולשמר ככל הניתן.
בטחון	- עבודה בסביבה בטוחה	- להיות קשובים לצרכים, אינטרסים וזכויות של אנשי המקצוע תוך נקיטת צעדים לאבטחת סביבה ותנאי עבודה הוגנים.
בריאות העובד	- הגנה מפני סיכונים מקצועיים	- תפעל להבטחת תקני בטיחות ותנקוט בפעולות לשמירה על בטיחות העובד.
יושרה מקצועית	- התרעה על כשלים התנהגותיים בארגון	- בדיקת הכשלים הארגוניים ושמירה על זכויות המתריע עידוד וחיזוק התנהגות אתית.
נאמנות מקצועית	- התרעה על כשלים התנהגותיים בארגון	- להגן ולתמוך בקבלת החלטות שנעשתה תוך שיקול דעת במסגרת כללי הקוד האתי.
כבוד הדדי	- הזכות להכרה בתרומה המקצועית הייחודית בתהליך הטיפול	- יצירת יחסי צוות ואווירת שיתוף פעולה, הערכה וכבוד בקרב עמיתים. - ליזום פעולות המחזקות ומטפחות הכרה מקצועית להכיר בתרומה ובייחודיות של המקצוע ובעלי מקצוע אחרים. לתאם ולפעול עם גורמים מקצועיים אחרים תוך כבוד הדדי.
מקצוענות	- לערוך מחקרים ולהשתתף במחקרים - לקבל הדרכה ולרכוש ידע עדכני	- להכשיר עמיתים וסטודנטים
חופש המאבק המקצועי	- התאגדות וחברות באיגון מקצועי - זכות לתנאי עבודה ושכר הולמים וזכות להיאבק עליהם.	- שימור ושיפור תנאי עבודה של העוסקים במקצוע. - תיידע מטופלים, עמיתים ואנשי ציבור על צעדי מאבק מותכננים או מופעלים.

פרק שלישי של סמית – מודלים, גישות ושיטות בהוראה והדרכה.

למידה פעילה (active learning)

הגדרה – שיטה המתייחסת לידע והמיומנויות שנרכשות אשר בבסיסם האחריות ללמידה היא של הלומד. לשיטת למידה טובה, על התלמיד להקשיב, לקרוא, לדון ולהשתתף בפתרון בעיות.

פעולות למידה התומכות בגישה זו ומשתמשות בהתנסות האישית של המדריך

- התעמקות
- סימולציות
- פתרון בעיות בקבוצות קטנות
- סיפורי מקרה.
- משחקי תפקידים – תרגול שיח או הדרכה למטופל.
- שאלונים ומשחקים
- סיעור מוחות

למידת מבוגרים (adult learning - andragogy)

הגדרה – הגשת תהליכי הלמידה המתקבלים דרך גישות המכוונות לפיתרון בעיות ושיתוף פעולה.

6 עקרונות למידה של KNOWLES

- הכוונה עצמית ומוטיבציה פנימית ללמידה
- ניסיון חיים
- מכוונים מטרה
- מכוונים ללמידת דברים רלוונטיים
- מכוונים ללמידת דברים שימושיים
- יחס מכבד.

סיפורי מקרה (case scenarios)

הגדרה – ניתוח מעמיק של סיטואציה הלקוחה מחיי המדריך במטרה לקדם למידה פעילה במהלך העברת חומר נלמד.

מטרה – פיתוח חשיבה ביקורתית דרך הוצאה לפועל של חומר עיוני לסיטואציות אמיתיות.

הנמקה קלינית

- שיקוף
- יכולת להשתמש במיומנויות בחשיבה ביקורתית תוך השוואה בין סיפורי מקרה שונים.
- פיתוח מיומנויות אנליטיות, פתרון בעיות ושיפור יכולת הסטודנט לקבלת החלטות במצבים מורכבים.

שיטת CBR (case based reasoning)

- היחידים מארגנים סוגים שונים של ידע תוך הסקת מסקנות המוכתבות מדעות אחרים.
- שיטה שנבנית עם מרכיבי הסביבה, שחקנים ומטרות, מהלך האירועים, תוצאות צפויות והסברים המקשרים בין המטרות והאמצעים לתוצאות.

התנהגות אנליטית

- יכולת האדם לזהות מאפיינים חשובים בסיטואציה חדשה ולהוציא לפועל ניסיון קודם בפתרון בעיות.
- אחיות משתמשות בחשיבה רפלקטיבית ותקשורת עצמית לפני, במהלך ואחרי ביצוע מיומנות מסוימת.

כשירות קלינית (clinical competency)

הגדרה – יכולת האחיות להוציא לפועל פעולות תוך השגת תוצאות רצויות תחת תנאי סביבה משתנים. האחיות יכולות לתכנן את פעילותן באופן מכוון אבל גם מפגינות גמישות ומהירות.

תכונות הכרחיות המעורבות בטיפול הכשיר

- ידע, גישות וערכים באים יחד עם אינטלגנציה רגשית וקוגניטיבית של האחיות

- מוטיבציה
- התבוננות פנימה
- יכולת הסברה
- בגרות
- יכולת לבצע הערכה עצמית.

הבסיס האתי לכשירות בסיעוד כולל

- יחסי אמות מטופל
- הרצון לעשות טוב
- שמירה על כבוד המטופל

כשירות שמומלץ לבחון אותם על בסיס שנתי

- מתן טיפול עם החולה במרכז
- שיתוף פעולה ביחן דיצפלינריות
- הבנה לגבי הגישה, פענוח וסינתזה של מידע
- שימוש בראיות מחקריות.

הערכים החשובים להשגת כשירות קלינית

- שמירה על בטיחות המטופל
- כשירות בפתרון בעיות
- יכולת חשיבה ביקורתית
- יכולת לצפות מראש גורמים שעלולים להשפיע על תוצאות הטיפול.
- מניעת שגיאות חמורות או גרימת נזק למטופלים

תרחישים קליניים (clinical scenarios)

הגדרה – התייחסות של אחות לאירועים רלוונטים שמתרחשים בפועל במפגש מול מטופל.

מטרה עיקרית – לפתח דרכים טובות למניעת טעויות וקידום בטיחות.

מטרות

- לפתח קביעת סדר עדיפויות, חשיבה ביקורתית, לימוד מיומנויות, הערכה ובהירות לגבי תפקיד האחות.
- שימור וחזקת של מיומנויות שנדרשות לטפל באירועים חריגים
- קידום תקשורת צוותית
- שיפור יכולת קבלת החלטות
- להבין מה ההשלכות של כישלון בסביבה נעימה.
- מהירות ארגון המידע
- ניתוח מידע וזיהוי הצרכים הנדרשים לפי סדר עדיפויות.

תנאים לתרחיש קליני טוב

- תכנון חומר כתוב מראש עבור סגל ההוראה ותסריט נפרד לסטודנט
- מותאם לרמת ידע של סטודנט והעלאת המורכבות של התרחיש עם התקדמות הזמן.

6 מרכיבים הכרחיים לבניית תרחישים על פי JEFFERIES

- מטרות
- תכנון
- נאמנות למציאות
- מורכבות
- אותות
- תדריך ותחקור.

לימוד קליני (clinical teaching)

הגדרה – הזמן בו המדריך והסטודנט מפתחים קשר במסגרת סביבה משותפת בה המדריך מכוון את התנהגות הסטודנט ליעדים רצויים.

קבוצות למידה – סטודנטים בשלבים מתקדמים חונכים סטודנטים חדשים.

חששות המערכת ביחס ללימוד קליני

- מחסור באחיות
- מחסור בתקנים של סטודנטים בשדות קליניים
- מגבלות כמות הסטודנטים פר מדריך
- תחרות עם בתי ספר לסיעוד אחרים

מפה רעיונית (concept maps)

הגדרה – כלים גרפיים הבאים לידי ביטוי בציורים או תרשימים שמתארים את הקשר בין או בתוך רעיונות והקשרים המנטלים שהסטודנטים יוצרים בין הרעיונות החדשים לקודמים.

יתרונות

- פיתוח חשיבה ביקורתית, ידע והבנה לגבי ההקשרים
- הדגמת עקרונות מפתח והקשרים המעורבים בטיפול במטופל.
- תכנון מהלך הלמידה על ידי ציור מפה לפני תחילת ההתנסות והתאמתה בהתבסס על הערכה בזמן מתן טיפול.
- מאפשרת עזרה בהבנה ובזכירה טובה של תהליכים מורכבים
- מקדמת מעורבות פעילה של הסטודנטים בתהליך הלמידה.

חסרונות

- לא מתאימה ללמידה קונקרטית או שמיעתית
 - דורשת זמן מצד הסטודנט וסגל ההוראה
- הערכה אינפורמטיבית – חיבור ניקוד עבור הסטודנטים שיכול להינתן לפי עומק הנתונים, עד כמה ההקשרים נכונים ועל בסיס תוכנית התערבות – עד כמה היא ספציפית, רלוונטית ומדויקת.

קבלת החלטות קליניות (clinical decision making)

הגדרה – תהליך שכולל שילוב ידע אודות מצבים פתולוגיים קיימים, נתוני המטופל, ניסיון קליני ושיקול דעת.

גורמים המשפיעים על קבלת החלטות

- רמת ידע
- מיומנות
- ניסיון חיים.

שיטות לתהליך קבלת החלטות

- הכי טובה – סיפורי מקרה
- איסוף מידע על מטופל – גישה מבוססת תיאוריה בה הסטודנט מתמקד בפרטים החשובים והרלוונטיים. מאפשרת למטופל להיות פעיל בטיפול בו.

קשיים בשימוש בטכנולוגיה (האחיות משתמשות בטכנולוגיה על מנת לספק נתונים אובייקטיביים מבוססי מחקרים)

- אחיות של מסתדרות עם טכנולוגיה – יעריכו אותה פחות
- השפעה מנתונים סוציודמוגרפיים של מטופל – גיל, מין, גזע, דת ומעמד סוציאקונומי.
- פערים בשירותי הבריאות כתוצאה מהטיות שמשיפיעות על תהליך קבלת ההחלטות.

חשיבה ביקורתית (critical thinking)

הגדרה – שילוב של 11 מרכיבים רגשיים (כמו סקרנות, בטחון ויושרה) ו7 מיומנויות קוגניטיביות (ניתוח, הגיון, ניבוי והמרת מידע).

אסטרטגיות לפיתוח חשיבה ביקורתית

- להגיד בקול רם את תהליך החשיבה שלהם בקבלת החלטות. מאפשר ללמד תובנות לגבי התהליך
- יומן רפלקטיבי
- מפות רעיוניות
- סיפורי מקרה.
- סימלוציות – מאפשרות הבנת הנרטיב ופרשנות של מצב קליני.

LCJR (lasater clinical judgment rubric) – מודל שמסייע ללמד חשיבה ביקורתית ושיפוט קליני. כולל:

- אבחנה
- פרשנות
- התערבות
- שיקוף.

שימוש בשאלות ברמה גבוהה מקדם חשיבה ברבדים עמוקים יותר – לדוגמה, במה הבחנת לראשונה במפגש עם המטופל.

4 מרכיבים המשפיעים על התפתחות חשיבה ביקורתית לפי CHAN

- תלמידים – קשיים בשפה או רקע תרבותי עלולים להפריע בתהליך רכישת מיומנויות.
- מחנכים – מחנך נגיש ותומך משפיע לטובה על התפתחות חשיבה ביקורתית
- מערכת לימודית – כל המחנכים צריכים להעריך ולקדם חשיבה ביקורתית, לספק הזדמנויות ללמידה פעילה
- סביבה – סביבה לימודית תומכת מקדמת רכישת מיומנויות של חשיבה ביקורתית.

DECISION CASE METHOD

הגדרה – כלי שמטרתו לפתח קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית בקרב סטודנטים. המדריך משתמש במקרים אמיתיים המתוארים חלקית. הסטודנט נדרש להיכנס לנעליים של מקבל ההחלטות ולהתעמת עם האתגרים של המקצוע.

המקרים כוללים:

- תיאור מדויק של הסביבה
- אנשי המקצוע המעורבים
- פרטי הרקע על המקרה
- המקרה עצמו.

יתרונות

- מבוססת ראיות
- מאפשרת יישום מחקר ותיאוריה במצבים אמיתיים בשטח
- למידה מהסטודנטים האחרים דרך העלאת נקודות מבט שונות
- מעודד שיתוף פעולה ולמידה בין מקצועית
- רכישת גיבוש המיומנות בסביבה בטוחה

התוצאות הצפויות

- פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית ושיפוטית
- תרגול קבלת החלטות
- למידה פעילה במקום למידה פאסיבית
- אינטגרציה של חומר במקום שינון בעל פה
- התנסות בנושאים אמיתיים מהשטח
- יצירת אווירת כיתה מעוררת ואינטראקטיבית עם הסטודנטים.

אתגר עיקרי – מציאת או פיתוח מקרים מתאימים. ניתן להתגבר עליו דרך עבודת צוות וחלוקת תפקידים.

תפקיד המדריך – לוותר על הסמכות הראשית המספקת ידע ולהפוך לכלי שמקדם למידה, משתמש בשאלות, מקשיב ומגיב במטרה להוביל את השיעור למטרותיו המוגדרות.

טיפול מבוסס ראיות (EBP)

הגדרה – גישה של פתרון בעיות קליניות המתבססת על ממצאים עדכניים במחקרים אמיתיים, מומחיות של מטפלים, ערכים והשקפות של המטופלים.

שלב 1- ניסוח השאלה הקלינית על פי PICO (המשת)

- P – patient – אוכלוסיית מטופלים
- I – INTERVENTION – התערבות או תחום עניין
- C – COMPRAION – קבוצת השוואה
- O – OUTCOME – תוצאה

שלב 2 – חיפוש חומרי מידע.

- שימוש במילות מפתח בכדי למקד חיפוש
- הרמה הגבוה ביותר של ראיות מדעיות – מאמרים מחקריים
- הרמה הנמוכה ביותר – חוות דעת או דוחות של וועדות מומחים.

שלב 3 – הסתכלות ביקורתית על החומרים שנאספו מהספרות. תוקף, אמינות ורלוונטיות למטופל.

שלב 4 – שיפוט קליני תוך התייחסות להעדפות המטופל וזאת על מנת להחליט אסטרגיית טיפול אשר מושפעת ממשתנים ארגוניים וקליניים (כמו מחסור במשאבים).

שלב 5 – הערכה של תוצאות ההתערבות – הצלחות וכשלונות.

- ניטור ומעקב אחרי שינויים במצב המטופל
- מדדי איכות
- זיהוי אוכלוסיית המטופלים שתפיק את התועלת המירבית.

שלב 6 – העברת הידע בצורה יעילה, מקומית ולאומית (דרך פרסום וימי עיון).

- מניעת ביצוע עבודות כפולות
- קידום אינטגרציה כסטנדרט בתהליך קבלת החלטות קליניות.

מחסומים

- מרבית האחיות שואלות קולגות שלהם ולא מחפשות מידע במקורות מחקרניים
- נאמנות למסורת והרגל
- חוסר זמן או יכולת להבין מונחים סטטיסטיים
- חוסר שיתוף פעולה מצד מנהלי הסיעוד או תרבות ארגונית.
- דרישות מרובות ולחץ (ריבוי מטופלים)
- מתודות מסורבלות שמובילות לחוסר עניין לעסוק במחקר.
- טכנולוגיה – בעיקר באחיות מבוגרות.

הומור (humor)

הגדרה – סוג של תקשורת המושפעת ממאפיינים אישיים ותרבותיים שמטרתה להפיק תגובה של בידור. מתוכננת או ספונטנית, שלילית או חיובית ותלויה בהקשר.

הומור כסגנון למידה – נגזרת מאופי המרצה.

- עדיפות להומור חיובי ומרומם רוח
- מתמקד בטעויות העצמי ומעלה תובנות
- מפחית סטריס
- יוצר קשר חיובי בין המדריך לסטודנט
- משפר את מעורבות התלמיד בלמידה
- יש להימנע מסגנון משפיל או שנוי במחלוקת!

הומור כטכניקה פדגוגית – העצמת למידה.

- העברת נושא, רעיון או מיומנות תוך למידה כיפית.
- כלי לימוד המעודד יצירתיות.
- מעורר חשיבה ביקורתית תוך אווירה נעימה
- הערכת הסטודנטים גדלה בעת השימוש בהומור.

הומור כטכניקה חברתית

- מגבש את הקבוצה, מבהיר תפקידים ומחזק נורמות קבוצתיות.
- הומור שחור – עוזר להתמודדות עם פחד, לחץ ושחיקה.
- יש להיזהר על מנת לא ליצור דה – הומניזציה של הסטודנטים או המטופלים עם הומור שלילי.

הומור כטכניקת תקשורת טיפולית בין אחות ומטופל

- מפחית רמות סטרס ומקדם רווחה בטיפול
- מקדם למידת מטופלים וגיוס שלהם לצורך הדרכה
- מחזק את הקשר עם האחות
- יש לשים לב להבדלים תרבותיים ולהדריך סטודנטים על גבולות בשימוש בהומור באינטרקציה עם מטופלים.

גישת הלומד במרכז (learner centered)

הגדרה – גישה שמתמקדת בלומדים אינדיבידואליים (ניסיון אישי, רקע והשקפות) וידע עכשווי (מוטיבציה והישגים) ומעודדת קבלת החלטות. יש התמקדות בסטודנט, הוא צריך להיות פעיל.

פעולות יישום

- תהליכים קוגניטיביים – יצירה, פתרון בעיות, הנמקה, קבלת החלטות והערכה.
- למידה פעילה ומותאמת לחיי הסטודנט.
- דרישה מהסגל להציב מטרות ברורות וספק משוב לאסטרטגיות הלמידה בהן השתמש הסטודנט.
- יש לספק סביבה תומכת, מתחשבת וחיובית.

מאפייני הגישה

- גיוס סטודנטים לעבודה קשה ומבולגנת – עריכת דיאלוג בין המרצה לסטודנטים, תוך הקשבה.
- מתן הוראות מדויקות לרכישת מיומנויות – חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות בשילוב עם התוכן.
- עידוד לביצוע רפלקציה – מאפשר להבין מה לומדים ואיך.
- שליטה על תהליך הלמידה והגברת המוטיבציה – האצלת הכוח של הסטודנטים
- עידוד שיתוף פעולה – למידה אחד מהשני. מעודד סטודנטים שמתקשים בלמידה.

מאפייני המדריך

- אוסף מידע על רקע הסטודנטים
 - קובע מטרות לימוד תוך התחשבות בצרכים אישיים
 - מפרט הוראות לימוד ובונה מערכי שיעור גמישים העונים על הצרכים.
 - משתמש בקבוצות לימוד שונות על מנת לעודד תקשורת.
 - מציב מטרות משמעותיות מנקודות מבטו של הסטודנט
 - מוודא כי יש אווירה נעימה ופתוחה המאפשרת שיתוף פעולה מצד הסטודנט.
 - מארגן את הכיתה באופן נוח לעבודה.
 - משתמש במטלות אותנטיות, פרקטיות ושימושיות להצגה בעל פה.
 - מבצע הערכות על בסיס התוצאות.
 - משתמש במגוון משאבים, מעבר לספר הלימוד.
- מאפייני הסטודנטים** – מרגישים בנוח לשאול שאלות ולעבוד בשיתוף פעולה תוך תקשורת.

יתרונות לעומת השיטה המסורתית

- השגת מטרות ושליטה בהן לטווח קצר
- שימור לטווח הארוך
- הבנה עמוקה
- רכישת חשיבה ביקורתית ומיומנויות יצירתיות לפתרון בעיות
- יצירת גישה חיובית כלפי הנושא הנלמד.
- הגברת רמת הביטחון בידע והמיומנויות

תוכניות טיפול (NURSING CARE PLANS - NCPs)

הגדרה – תוכנית מובנית לעבודה הסיעודית שמהווה רישום המשקף את התהליך הסיעודי.

התהליך הסיעודי – גישה של חשיבה ביקורתית במטרה לזהות ולטפל בבעיות סיעודיות. מספק הנחיות טיפול שמסייע למטופלים ומשפחותיהם להגיע לטיפול מיטבי.

מרכיבים בתהליך הסיעודי

1. **הערכה** – איסוף נתונים אובייקטיביים וסובייקטיביים – אנמנזה, אומדן גופני על מנת לבנות תוכנית טיפולית.
2. **אבחנה** – בהתבסס על ממצאי הערכה, שיפוט קליני אודות חוויות או תגובות לבעיות בריאות באוכלוסיות שונות.
3. **תכנון** – קבלת החלטות לגבי התוצאות הטיפוליות הרצויות המתמקדות במטופל. צריכות להיות ספציפיות, מדידות, אפשריות, ריאליות ומוגדרות בזמן.
4. **התערבות** – כל טיפול שהתבסס על השיפוט הקליני של האחות במטרה לקדם תוצאות.

5. הערכה חוזרת – קביעה האם המטרות הושגו וביצוע שינויים בתוכנית טיפול לפי הצורך.

שימוש בתוכניות טיפול ממוחשבות

- יעילות יותר עקב שימוש ברשומות רפואיות
- מאפשרות לבנות מאגר נתונים עשיר במטרה להריך את התרומה של הסיעוד בטיפול.
- חסרונות של השיטה
 - נגישות מוגבלת
 - יעילות ירודה
 - חוסר יכולת לתת טיפול אינדיבידואלי
 - מחסור במומחיות בסיעוד
 - ענייני החוק והפרטיות

למידה מבוססת שאלות (PBL)

הגדרה – אסטרטגיה המקדמת למידה שדורשת מהסטודנט להפעיל חשיבה ביקורתית, להיות מכוונים עצמאית ומיומנים בפתרון בעיות תוך שימוש במקרים מציאותיים.

סיפור מקרה – מעודד דיאלוג אינטרקטיבי בין חברי הכיתה הפועלים יחד להבנת הסיפור תוך איסוף מידע לסגירת הפער בידע.

פיגומים רכים – דינמיים ומבוססים על פעולות סגל ההוראה במטרה לתמוך בצרכי הלומד.

פיגומים קשים – סטטים ויכולים לכלול דפי עבודה וכלים קוגניטיביים אחרים.

FLEXIBLE SCAFFOLDING – ככל שהסטודנט מתרגל שאלות, המומחיות שלהם גוברת והם נדרשים לפחות הכוונה ופיגומים.

תפקיד המדריך – להעריך את הסטודנט בצורה מספרית ואיכותית תוך שימוש בראיות לכך שהסטודנט מצליח ליישם ידע, לדון בסיפורי מקרה ולהפוך למיומנות בחשיבה ביקורתית ופתרון בעיות.

מיומנויות פסיכומוטוריות (psychomotor skills)

הגדרה – פעולות של תנועות שמערבות תגובה פיזית גלויה עם תהליך מנטלי נלווה. דורשת הבנת המיומנות והדרכים לבצע את הפעולה וכן היישום שלה.

שלב מקדים – למידת התיאוריה והעקרונות שעומדים בבסיס המיומנות ואמידת ההבנה שלהם.

שלב ראשון – תרגול הקוארדינציה הדרושה לפעולה. אין לשאול על עקרונות המיומנות על מנת לא לעכב למידה.

שלב שני – תרגול וחזרתיות – על מנת לעדן מיומנות, להגביר עקביות ולפתח אוטומטיות בפעולה. שיעורי תרגול עם מרווחי זמן ביניהם.

פאזות ללמידה ופיתוח מיומנויות

- קוגניטיבי – הבנת הפעולה וביצועה.
- אסוציאטיבי – הסטודנט לומד לבצע את הפעולה בצורה היעילה ביותר תוך עידון הכישורים עד שהופכים לעקביים.
- אוטונומי – המיומנות הופכת לאוטומטית. רק לאחר תרגול רב.

שלבים בטקסונומיה בהקשר של גישה זו

1. ביצוע על ידי חיקוי – צופים בהדגמה ומבצעים לאחריה.
2. לאחר תרגול, הסטודנטים יכולים לבצע פעולה בעזרת תדריך כתוב.
3. ביצוע המיומנות בצורה מדויקת
4. ביצוע המיומנות במסגרת זמן סבירה.
5. ביצוע אוטומטי באופן טבעי כחלק מהטיפול הרוטיני במטופל.

אינטגרציה של תיאוריה לפרקטיקה (theory practice integration)

הגדרה – שימוש ברעיונות, ערכים ומחקר בסיעוד על מנת להנחות ביצוע מכון ברמת מיומנות גבוהה מעבר לפעולות רוטניות ובמטרה למנוע או לפתור את בעיות המטופלים.

- תיאוריה ופרקטיקה מוזנות ומובנות אחת מהשנייה.
- בעיות חדשות בפרקטיקה – פערים בידע וחיפוש אחר מחקרים חדשים.
- על מנת להצליח בפרקטיקה צריך להשתמש בתיאוריה.

רפלקציה במהלך פעולה – שימוש בתיאוריה של פתרון בעיות במידע תוך שימוש בתהליך מטה קוגניטיבי עם התגלגלות לאירוע.

- הסטודנטים משתמשים בתוכנית טיפול (הערכה, אבחנה, תכנון, יישום, הערכה חוזרת).
- סטודנט שמסרב לקחת אחריות – מוביל לתקיעות, שעמום ועזיבת לימודים.
- חוסר התבססות על ידע תיאורטי – התערבויות לא מותאמות שאינן פותרות את בעיות המטופל.
- הנחייה בצורת רפלקציה מחזקת אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה.
- המחנכים צריכים להיות מודעים לפחד של הסטודנטים לקחת סיכון ואחריות בקבלת החלטות ולסייע להם להתמודד עם זה.
- מחנכים צריכים לעודד סטודנטים להשתמש במקורות מהימנים כמו מחקרים אקדמיים.
- קידום הסטודנטים מעבר לשינון מיומנות טכנית לעבר רפלקציה בתוך הפעולה.

הערכה פורמטיבית

- מספקת משוב עבור חשיבה לא נכונה
- מכוונת מחדש את הסטודנט לחפש פתרונות נוספים
- מספק הזדמנויות להדגמת קבלת החלטות קליניות והנחייה בתהליך של רפלקציה.
- יוצרת מודל לימודי בין המדריך לסטודנט תוך ניסוח בעיות ממוקדות מטרה עבור המטופל והסטודנט.

למידה מהפכנית (TL)

הגדרה – תהליך של שינוי המתייחס נושא מסוים ומעורר שאלות לגבי השערות האדם ומוביל להשקפה מהפכנית בנוגע לסיטואציה.

- מאפשרת לסטודנט להיות עצמאי
- רפלקציה במהלך פעולה היא שיטת לימוד טובה למידה מהפכנית
- מבוגרים מטילים ספק בהשערות, צריכים לשאול שאלות ולהמשיג את הבעיה בהקשר החברתי, הפוליטי והכלכלי של חייהם.

מסגרת ההקשר (frame of reference) – הדרך בה האדם רואה את העולם.

- תפקיד המדריך – לשאול בעדינות שאלות שמגרות חשיבה ותובנה במטרה לשנות את זווית הראייה של הסטודנט.
- יש לאפשר לסטודנט זמן להבין את הבעיה תוך איתור השערות חיוביות ושליליות בבסיס הבעיה.
- לאחר שזוהו ההשערות – הסטודנט מבצע רפלקציה עצמאית בכדי לגלות את המקור להשערות.
- לאחר זיהוי המקור – שיתוף ממצאים עם חברי הקבוצה על מנת לפתור בעיות
- לבסוף הסטודנט מכיר במסגרת ההקשר ומשיג השקפה שונה.

אמון – הכרחי לפיתוח למידה מהפכנית. סביבה מתאימה, אינה מאיימת, תומכת ומקדמת יצירת אמון. המחנך צריך להקדיש זמן לכל הסטודנטים ולהכיר את הרקע של כל סטודנט.

לימוד מכון עצמי (self-directed learning)

הגדרה – תהליך שמעודד לומדים מבוגרים לקחת אחריות אישית ללמידה על ידי קביעת מטרות לימודיות לפי צרכיהם, זיהוי והשגה של מקורות ומשאבי למידה, ביצוע פעולות המקדמות למידה והערכת תוצאות הלמידה.

עקרונות הליבה

- מוטיבציה פנימית
- אדם מחושב
- יכולת לקבל הנחייה
- הערכה עם או בלי סיוע של האחרים

יתרונות

- פיתוח מיומנויות של תשאול
- השגת ידע חדש שרך העלאת רמת הביטחון של הסטודנט
- גמישות בסיטואציות לא מוכרות
- עצמאות

תפקיד המדריך

- ליצור אווירת למידה מכבדת
- לשמור על עניין
- לתמוך בפיתוח ידע ומיומנויות.

שיטות להשגת SDL

- רפלקציה
- לימוד עצמי
- דיון
- עבודה בקבוצות
- מודל ללימוד מרחוק
- ייעוץ טלפוני.

פרספקטיבות עיקריות לגבי השימוש ב־SDL בחינוך

- לוקח בחשבון את רמת הלימוד של הסטודנט והתהליכים הארגוניים הדרושים לקדם SDL
- פיתוח לומדים בעלי אוטונומיה אינטלקטואלית.

תוצאות

- ככל שמוכנות הסטודנט נמוכה, כך רמת החרדה גבוהה מול התמודדות של מטלות
- ככל שהסטודנט עם מוכנות גבוהה, כך רמת החרדה ממטלות עם הנחיות מרובות גבוהה יותר.

סימולציות

הגדרה – אסטרגיית לימוד פעילה שמשתמשת במכשירים או טכניקות על מנת לבנות סביבה שדמה סיטואציה קלינית ומאפשרת הערכה של מיומנויות, חשיבה ביקורתית ותקשורת בצורה בטוחה.

מטרה – יכולת ליצור סביבה מוגנת, מציאותית ולימודית בה הסטודנטים מיישמים את הידע שרכשו תוך שיתוף פעולה ותקשורת וליישם קבלת החלטות קליניות תחת השגחת המדריכים.

מאפיינים

- תהליך דינמי
- יצירת הזדמנויות היפותטיים המצוגים באופן אותנטי וריאליסטי
- גיוס הסטודנטים לפעולה
- אינטגרציה של המורכבויות בלמידה התיאורטית והמעשית.
- הזדמנות לחזרות, מתן משוב, הערכה ורפלקציה.

יתרונות

- הפחתת חרדה
- הגברת שימור ידע וביטחון עצמי
- פיתוח מיומנויות פסיכומטריות
- שיפור חשיבה ביקורתית
- שיפור התקשורת בסביבה בטוחה.
- סביבה לא מאיימת המאפשרת העצמת למידה והגברת תחושת מוכנות בשטח.
- הנאה ואתגר
- מותאמת לתכני הקורס.

חסרונות

- תחושת בלבול וחוסר הבנה כשמצב המטופל משתנה.
- הסטודנטים לא מפתחים את היכולת לפענח דקויות ושפת גוף במפגש עם המטופל.

ניקוד גבוה	ניקוד נמוך
- תחקיר מודרך	- צפייה בהקלטה של סימולציה
- רפלקציה לאחר סימולציה	- סיכומים על המקרה.
- הובלה על ידי המדריך	

סימולציה: הגיון קליני

הגדרה – תהליך בו יש הפעלת שיקול דעת, ניתוח ראיות לפתרון בעיות וקבלת החלטות טיפוליות בו מחליטים מה הטיפול המתאים ביותר למטופל.

HEPs – שיטה בה הסימולציה כוללת תחקיר שמאפשר ללומד הזדמנות לבצע רפלקציה על הסימולציה.

- משפרות חשיבה ביקורתית והגיון קליני במצבים טיפוליים מורכבים
- מגבירה את הבטחון העצמי של הסטודנט.

אתיקה בסימולציות

הגדרה – מסגרת עבודה בה נמצאים הסטודנטים והמדריכים המשתתפים בסימולציה במטרה להגדיר דברים נכונים ולא נכונים תוך חשיבות עשיית טוב ואוטונומיה.

מטופלים

- אין לחשוף מטופל לסיכון מיותר
- יש לאפשר לו להחליט על הטיפול בו
- מטופלים עם חוסר כלכלה נוטים להיחשף לטיפול לא מקצועי – נמצאים בסיכון לחזור בביצוע פעולות, חשופים לאי נוחות וטעויות שהיו יכולות להימנע.

מעבירי הסימולציה

- פיתוח סיטואציות מותאמות ומדמות מציאות עד כמה שניתן.
- העברת תחקיר והערכה מותאמת שמעודדים למידה והפקת לקחים
- יש לנקוט ביחס מכבד ומחויבות לסודיות

סטודנטים

- מחויבות לשמור על סודיות התרחיש על מנת לאפשר תהליך למידה גם בסטודנטים אחרים.
- להפגין נכונות לפעול כאילו המקרה היה אמיתי.
- עוזרות לסטודנטים להתנהל באופן יעיל אחד עם השני וקבלת תוצאות טיפול חיוביות עבור המטופל.
- עוזרות לזהות טעויות ולמנוע אותם.

המשוב לסימולציה – שיקוף ורפלקציה.

תקשורת – שימוש בסימולציה מסייע בתרגול תקשורת יעילה בין הצוותים, מגבירה את בטיחות המטופל ומשפרת תוצאות טיפוליות.

סימולציות: פיתוח צוותים

הגדרה – כלי לשיפור כשירויות בחינוך הנדרשות למדריכים לצורך שיפור מציאות אקדמית.

מטרה – העצמת המדריך להיות ייחודי ועידוד למידה מיטבית של המדריך והסטודנטים.

טכניקת HEPs – מדמה מציאות גבוהה. במודל זה לכל רמה יש כשירות המתרכזת ביעדי לימוד שעוזרים למדריך להתקדם בשלבים השונים ומאפשרים פיתוח מדריכים ללימוד סימולציה.

טכניקת STEP – מאפשרת להכיר את האספקטים החשובים של לימוד בעזרת סימולציה.

SIRC – קורסים אינטרנטיים לעיצוב התרחיש, העברת משוב והנחיית רפלקציה, אסטרטגיות למידה ועיצוב מרכזי הסימולציות.

סימולציות – מטופלים מדומים

NESF – מסגרת תיאורטית המסייעת לעצב, להוציא לפועל ולהעריך את אסטרטגיות הלימוד של הסימולציות במסגרת הלימודים.

אסטרטגיות למידה – מאפשר למדריכים להתמקד בדרך בה הסטודנטים לומדים ומאפשרת לספק את האמצעים לייעול הלמידה והמיומנויות של חשיבה ביקורתית.

מאפייני הסטודנטים – מכוונים ללמידה עצמית ובעלי מוטיבציה ללמידה ולקחת אחריות

מאפייני המדריך – תמיכה בהדרכה וטכנולוגיה הדרושים בכדי לעצב ולהוציא לפועל אסטרטגיות חדשות.

עיצוב הסימולציה – צריכה לתמוך במטרות של הקורסים הנלמדים. יש לשלב אספקטים של מורכבות, נאמנות למציאות, אותות לפעולה ותחקיר בתוך החוויה הלימודית

כלים למדידת תוצרים – רפלקציה וחשיבה ביקורתית. יש לקבוע מראש את היעדים.

סימולציות בין צוותים (IPS)

הגדרה – סימולציה שכוללת סטודנטים ומדריכים משני מקצועות או יותר אשר מתחברים יחד כדי ליצור פעילויות למידה משותפת שמדמה מצבים מהמציאות.

מטרה – להעמיק את הידע, לשפר תקשורת ומיומנויות קליניות ולהעצים גישה מכבדת שמאפשרת עבודת צוות.

כשירויות לחינוך איכותי ובטוח המושלבים ב-IPS

- טיפול ממוקד בחולה
- שיתוף פעולה ועבודת צוות
- טיפול מבוסס ראיות
- שיפור איכות טיפול
- בטיחות
- אינפורמטיקה (מידענות) – שימוש מושכל במידע לצורך השגת יעד מוגדר.

מחסומים ביישום ה-IPS

- משאבים מוגבלים – המחסום המדובר ביותר. כולל עלויות וכיצד מתחלקות בין מקצועות שונים.
- חוסר הכרה מצד ההנהלה בעומס עבודה
- קושי לתאם זמן בין הצוותים או בין התוכניות.
- התנגדות סגל ההוראה וההנהלה לביצוע שינויים ושיתוף פעולה עם תוכניות לימוד אחרות

סימולציות של בטיחות במתן תרופות

הגדרה – מאפשרות למידה של מיומנויות מהילת והכנת תרופות, חישוב מינון, ריכוז וקצב עירוי. מאפשר הזדמנות להכין ולתת תרופות מורכבות שלא מתאפשרות בהתנסויות הקליניות או באירועים קריטיים.

תרגול טעות במינון – מאפשרת חשיבה ביקורתית בקרב הסטודנטים ומניעת טעויות.

יתרונות

- מניעת טעויות
- מתן הזדמנות להדגמה על ידי מומחה בצורה נכונה ביותר
- למידה עם הנחייה ותמיכה
- רפלקציה מונחת פעולה
- אפשרות להטמיע את התרבות של הטיפול הבטיחותי וחשיפתם לגבי המרכיבים החיוניים.

סימולציות של בטיחות מטופלים

מניעי המפתח להמשך המאמץ לקידום ופיתוח הסימולציות

- ציבור
- חברות ביטוח
- ארגוניים מקצועיים
- גופי אקדמיים
- ארגונים רגולטוריים וממשלתיים.

הערכה של סימולציות

הגדרה – תהליך של איסוף מידע וחזרה על החומר במטרה לקבל החלטות מושכלות ולשפר את יעילות תוכניות הסימולציות.

אתגר- מסגרת עקבית למדידה והערכה של התוצאות. יש להעריך את התנהגות הסטודנט בתחום הרגשי, הקוגניטיבי והפסיכומטורי.

יצירת תרחיש סימולציה

מרכיבי המודל המסייע למדריכים בסיעוד בעת יצירת תרחיש סימולציה

- מידע
- פתרון בעיות
- תמיכה בסטודנט
- נאמנות
- תחקיר.

תנאים הכרחיים לתרחיש סימולציה

- מבוססי ראיות מחקריות לטיפול איכותי ובטיחות
- יש צורך לעבור תיקוף על ידי עמיתים לעבודה ומבחני פיילוט.

שלב 1 – הדגשת יעדים - קשורים למיומנויות פתרון בעיות שנדרשות למתן טיפול ומותאמת לסטודנט.

שלב 2 – תכנון הזמן – הקדשת זמן לביצוע התרחיש ולתחקיר אחריו. יש לעמוד בזמן שהוגדר.

שלב 3 – חלוקת תפקידים – התאמה לסטודנטים שונים (רופא, אחות, בן משפחה וכו). מפתחת מיומנויות תקשורת.

שלב 4 – רפלקציה – יש לעצב שאלות רפלקציה שישמשו בשלב התחקיר המאפשרות לסטודנט להסתכל על הסיטואציה שוב.

שלב 5 – תחקיר – מתבצע בסוף הסימולציה ומאפשר לסטודנט להעריך את הסיטואציה.

למידה מהפכנית בסימולציות

הגדרה – סימולציות שמערבות שימוש בבובות דמויות אדם או שחקנים שמדמות מציאות ברמה נמוכה או גבוהה (גרסאות טכנולוגיות שמחקות תגובה פיזיולוגית של האדם).

הנחיות לסימולציה של התנהגות

- שילוב סימולציות המדמות את המציאות והמורכבות ברמה נמוכה על מנת למנוע בהלה.
- חזרתיות של החוויה הנלמדת
- תוספת לידע תיאורטי ושילוב של למידה מודולרית (מכוונת לתוצאות).

הנחיות לסימולציה בונה

- גישה למגוון משאבי מידע במעבדות סימולציה
- משא ומתן לגבי יעדי הלמידה בין המדריך והסטודנט
- יצירת תרחישים שכוללים אי וודאות ומצבים עם דחיפות מוגברת ורעשי רקע.

התיאוריה למידה מהפכנית

- שילוב תהליכים קבוצתיים ודינמיים להעמקת הידע.
- ביצוע רפלקציה ביקורתית
- שינוי בסכמות ופרספקטיבות הסטודנט.
- יש להתאים את התרחיש לסטודנט ולהעלות את רמת המורכבות בהדרגתיות
- יש להימנע מחשיפת הסטודנטים לסיטואציות טעונות רגשית בכדי לא לדכא יכולות קוגניטיביות.

כתיבה רפלקטיבית (reflective writing)

הגדרה – מטלה שמערבת חשיבה מכוונת וכוללנית על מחשבות, רגשות ואינטראקציות שהתרחשו במהלך ההתנסות הקלינית. מעלה את המודעות העצמית וגורמת לשיפורים בביצוע.

סוגי כתיבה רפלקטיבית

- כתיבה אקדמאית במהלך תוכנית הלימודים
- פדגוגיה נרטיבית – שיתוף בחוויות מול קבוצה אך אין לחייב את הסטודנט.

- תוכניות כתיבה – במטרה ללמוד.

שלבי הרפלקציה

1. **מודעות למחשבות ורגשות לא נעימים או מפתיעים** – דאגה לגבי מצב המטופל המלווה בחרדה ולחץ מעשיית טעויות.
2. **ניתוח ביקורתי על התופעה** – מה הוביל לטעות.
3. **פיתוח פרספקטיבה חדשה** – מה ניתן לעשות כדי למנוע את אותה הטעות.

מודלים בכתיבה רפלקטיבית

- מודל ארבעת הצעדים של באקר- מותאם לסטודנטים חדשים
- מודל של ג'ונס – מורכב משאלות מכוונות ל5 דפוס ידעה – אתי, אישי, אסתטי, אמפירי ורפלקטיבי.
- מודל CRI – מודל חדש שמנחה את הסטודנטים ב3 רמות חשיבה – תיאורי, רפלקטיבי וביקורתי.

חסמים לביצוע כתיבה רפלקטיבית

- **חוסר זמן** – לבצע רפלקציה על ידי הסטודנטים או של הסגל לתת ציון למטלות אלו.
- **חשש לציון נמוך** – סטודנטים רושמים את מה שהמדריך רוצה לשמוע ולא מה שהם חושבים.
- **קושי במתן ציון למטלות** – מומלץ להעריך אותם בתור תהליך ולא ציון.
- **העדפה של מטלות קצרות** – יכול לגרום למדריך לחסוך מהסטודנטים מצבים מורכבים.
- **חוסר אמון במדריך** – עלול לעורר חרדה ופגיעות, היות והסטודנט נדרש לחשוף את עצמו. המדריך צריך לתמוך בסטודנט באופן גלוי ולא שיפוטי.

אומנות ורפלקציה

אומנות – ביטוי או יישום של יצירתיות ודמיון במטרה ליצור חפצים, סביבה או חוויה אסתטית ולחלוק אותה עם אחרים.

- צפייה באומנות מאפשרת ליצור חזון
- מאפשרת ללמוד התערבויות המשפרות את איכות חיי המטופלים.
- רפלקציה עצמית – מודעות פנימית למחשבות, רגשות, שיפוטיות ותפיסות.

רפלקציה על אומנות

- מסייעת למטופל לחקור רגשות, לפתור קונפליקטיים רגשיים, להגביר מודעות עצמית ולהתנהל עם הפרעות התנהגות והתמכרויות.
- מפחיתה חרדה ומפתחת מיומנויות חברתיות
- מסייע לסטודנטים למודעות עצמית, אמפתיה, חשיבה ביקורתית וחברתיות וכן משפרת יחסים בין צוותים
- סוגי אומנות – משחקי תפקידים, הצגות, סמינרים, סיפורי מקרה, ציור, כתיבת שיר, דימיון צילום ומפות רעיוניות.

הנושאים העיקריים העולים מהתיאוריה

- שילוב תיאוריה עם פרקטיקה - להשתמש בידע קליני לצורך הבנת התיאוריה בעת יישום תיאוריות
- מודעות תפיסתית – הבחנה ברלוונטיות בסיטואציה קלינית. נובעת מידע נרכש וחיבורו לניסיון קודם.
- מומחיות קלינית – דאגה ואחריות מוסרית כלפי מטופלים בחוויות הכי אינטימיות כמו סבל.

טירון (NOVICE) – השלב הראשוני ביותר -סטודנט לסיעוד.

- קבלת ידע תיאורטי וכללים להתנהגות במצבים קליניים
- האתגר – הסטודנט עדיין לא מצליח לגמרי לקשר בין התיאוריה לפרקטיקה.
- על הסטודנט להתאים את הטיפול למטופלים ספציפיים, בשלב זה, עוד לא מצליח.

תפקיד המדריך הקליני

- להראות לסטודנט את הקשר בין תיאוריה לפרקטיקה וליצור ידע קליני.
- לסייע לסטודנט להבחין בדימיון והשוני בין סיטואציות שונות על מנת להבין את הניוסים במצבים טיפולים (לדוגמה הזעה עקב אוטם או עקב אימון).
- **רפלקציה ביקורתית** – מאפשרת לקלוט פרטים שהתפספסו וליצור סדר בגירויים בסביבה הקלינית. כתיבת יומן מספקת משוב עבור סטודנטים בעלי בטחון עצמי נמוך ומאפשר למדריך להבין את הסטודנט.

מתחיל מתקדם (ADVANCED BEGINNER) – סטודנטים שסיימו את לימודיהם.

- הסטודנט מזהה מרכיבים ייחודיים של סיטואציות.
- הסטודנט מודע למורכבות בכל סיטואציה קלינית
- קיים קושי בתרגום התיאוריה להשלכות הפרקטיות עבור מטופלים עם מספר בעיות במקביל.
- ישנה מודעות נמוכה לצרכי המטופל והשלמת מטלות – היא העיקרית. (ראיית מנהרה).

כשיר (COMPETENT)

- אחות שיודעת לזהות ולהתערב במרכיבים הרלוונטים בסיטואציות קליניות שונות תוך ארגוןם לפי סדר עדיפויות.
- פחות תלות בכללים אלא ארגון הסיטואציה לפי ניסיון קודם.
- עלייה במעורבות עם המטופל
- עלייה בתחושת האחריות האישית ביחס להחלטות שמתקבלות כלפי מטופלים.

מיומן (PROFICIENT)

- פעולה בצורה אינטואיטיבית. כל מטופל וסיטואציה מקבלים התייחסות אינדיבידואלית.
- פחות עיסוק ברפלקציה מנותקת בנוגע למתרחש.
- עדיין ישנו צורך בלחשב פעולות

מומחה (EXPERT)

- האחות עם התפיסה האינטואיטיבית הגבוהה ביותר
- מובנית על ניסיון של שנים.
- הידע כיצד לפעול בסיטואציה מבוסס על היכרות עם המטופל והידע לגבי מצבו באופן שווה.

פרק עשירי של אוקונר – אסטרטגיות למידה בהדרכה

טכניקות כלליות ללמידה בסביבה הקלינית

המטרה בהדרכה קלינית – לחבר בין תיאוריה לפרקטיקה על מנת לפתח חשיבה ביקורתית, מיומנויות טכניות ותגובות אתיות בסיטואציות קליניות שונות.

שני אספקטים של אימון

- פיתוח מיומנויות פסיכומטריות תוך הדגשת גישה אכפתית
- להוביל להבנת התיאוריה כפי שבאה לידי ביטוי בפעולות הסיעוד.

הצבת מטרות

- חיוני להצלחה בפעולות פסיכומטריות.
- מטרות קצרות טווח מעלות מוטיבציה.
- מטרות ארוכות טווח מאפשרות לסטודנט לבצע הערכה עצמית לגבי ההתקדמות שלו.
- גישה מבוססת ביצועים.
- המטרות צריכות להיות **ריאליות** – מאפשר להגיע לרמת ביצוע גבוהה יותר. יש לקבוע בשיתוף הסטודנטים מטרות אלה.
- המטרות צריכות להיות **מאתגרות** – שמירה על רמת מוטיבציה גבוהה. כאשר הרף נמוך – חוסר התאמצות והישארות במקום הבטוח.
- **חזרה מנטלית** – המדריך מתאר באופן מילולי את הפעולה, השלבים שלה ותגובת המטופל הצפויה ובכך עוזר לסטודנטים לדמיין את הסיטואציה. עוזר בזמן ביצוע פעולה פעם ראשונה.

אימון קוגניטיבי

- פיתוח תבניות עבודה מקצועיות לטיפול מתוך הסיטואציות שחוו.
- תחילה יש להבין את ההבנה של הסטודנט לגבי הבסיס התיאורטי.
- בשלב השני תיאור לסטודנט מה המדריך ראה ושאלת שאלות פתוחות על מנת למקד בתהליך קבלת החלטות בסוף, הדגמת התהליך החשיבתי דרך רצף ותוכן השאלות – מעודד דפוס הסתכלות לגבי סיטואציה.

שאלת שאלות

- **עבור המדריך הקליני** – מספקת תובנה לגבי רמת המוכנות של הסטודנט והיכולת להתמודד עם דרישות של מטלות והבנה לגבי דינמיות של מצב המטופל.
- **עבור הסטודנטים** – השגת ידע וביצוע רפלקציה. מאפשר חשיבה בקול ושימוש בחשיבה ביקורתית.

סיפורי מלחמה

- תיאור אירוע משמעותי מהעבר של האחות המאפשר פרדיגמה כללית עבודה מנחים כאשר נתקלים בסיטואציה דומה.
- משלבת טיפול מבוסס מהשטח והניסיון הקליני.
- הסיפור נחרט בראשם של הסטודנטים כמפגש טיפול אמיתי.
- מאפשר להפשית סיטואציות ולהסיק מסקנות מבלי להיות מעורבים בסיטואציה עצמה.
- עוסקים במפגשים מורכבים עם פוטנציאל גבוה לנזק. יכולים להיות שליליים או חיוביים.

הקשבה

- **ניסוח מחדש של הנאמר** – מאפשר לסטודנט לתקן אי הבנות או להרחיב לגבי אמירה מסוימת.
- **בדיקות לגבי התפיסה** – יש לדווח את מסקנות המדריך לגבי התנהגות הסטודנט. מאפשר לסטודנט להבין את הסיטואציה שמקשה עליו.
- **סיכום** – מסייע לזהות את הקשרים בין ההצהרות השונות ומספק משוב. מאפשר לתקן אי הבנות.
- **הצהרות של "אני"** – התגובה של המדריך הקליני להצהרות הסטודנט מבלי להשליך את האחריות לתגובה על הסטודנט. מזמין חקירה משותפת לבירור הסיבות ולא האשמה.

הדגמה

- מתאפשרת בדפוס של הסברה, הדגמה וגרימת תגובה.
- המדריך מבצע דיון לגבי ההסתכלות והרציונל שלו, העלאת אבחנות והשערות אפשריות לסיטואציה.
- המדריך צריך להסביר את הדרך בה הוא חיפש מידע ולבצע הערכה נוספת של הסיטואציה עד מציאת האבחנה הסבירה ביותר ושקילת אלטרנטיביות טיפוליות.

השגחה על ביצוע מיומנויות טכניות של סטודנטים

מטרה – לשתף פעולה עם הסטודנטים בביצוע מיומנויות ולסייע להם להרחיב את ההסתכלות בפן הטיפולי ובכך לנצל את רמת המוכנות של הסטודנטים ללמידה.

- מתחיל בתפיסה כללית של הלומד והכנה מנטלית, פיזית ופסיכולוגית לביצוע הפעולה.
- **ביצועים ראשוניים** – חיקוי הרעיון שנצפה דרך הדגמה. גישה של ניסוי וטעייה על מנת לפתח ביטחון טכני בביצוע פעולה.
- **ביצועים חוזרים** – לאחר מספר חזרות הסטודנט מבצע את המיומנות באופן חלק ומותאם עם רצף של פעולות.
- **הדגמה חיה** – כוללת שימוש בבובה, סטודנט או מטופל שמשתף פעולה ללא דחיפות בביצוע המיומנות ועם מעט גורמים חיצוניים שמשפיעים על הסיטואציה.

חסרונות אצל סטודנטים והדרך בה המדריך יכול לפתור אותם

חסרונות	המדריך הקליני
<u>שכיחת הצעדים</u> לביצוע המיומנות שנלמדו בזמן הסימולציה	<u>קידום חוסר תלות בצעדים</u> – קיבוץ צעדים. לתת שמות לקבוצות מסוימות ובכך לצמצם את רשימת היעדים שהסטודנט צריך לזכור
<u>חוסר מודעות לגבי המכשולים</u> בסביבה המעיקים על ביצוע הפעולה (גובה מיטה, דפנה מורמת, תנוחה בה המטופל נמצא)	לדוגמה – החלפת חבישה תתחלק להכנת שדה סטרילי, הסרת חבישה ובדיקת פצע, טיפול וחבישה מחדש.
<u>רמת חרדה גבוהה בעת ביצוע פעולה</u> – עמידה בתנוחה מוזרה מול המטופל, שמירת מרחק מהמטופל. מפריע לביצוע המיומנות לקליטת סיגלים שתורמים למודעות הגופנית ולתנועות הנדרשות לביצוע המיומנות.	הדגשת מרכיב הכנת הסביבה לפני פעולה כחשוב כמו כל תהליך איסוף ציוד המתאים לפעולה.
<u>נטייה לחסוך בתנועות גוף</u> – ינסו להשתמש ביד אחת בעת ביצוע הפעולה או שימוש ביד ללא הזזת פרק היד.	<u>פיתוח מודעות לגוף</u> הסטודנט והפחתת מתח באמצעות <u>תרגילי הרגעה</u> : כיווץ והרפיית שרירי הצוואר והכתפיים, גלגול ראש וניעור הזרועות והידיים או ביצוע מספר נשימות עמוקות.
<u>שיכחת המטרה</u> – לשם מה נעשית הפעולה ומה התוצאה הרצויה	<u>תזכורת לגבי השימוש ביד</u> הלא דומיננטית המסייעת במיומנות או שומרת על מגע פיזי עם המטופל.
	<u>תמונה ויזואלית</u> לגבי התוצאה הרצויה מהפעולה. לדוגמה- כיצד חבישה חדשה צריכה להיראות.

כיצד לשחרר

- יכולת המדריך לשהות בסיטואציה עם סטודנט ומטופל מבלי להשתלט על ביצוע הסטודנט.
- נוכחות משקיפה ומתן רמזים לסטודנט לגבי השלב הבא.
- השתלטות גורמת לפגיעה בביטחון העצמי של הסטודנט, השפלה ופגיעה באמון.
- מצבים בהם ההשתלטות הכרחית – הסטודנט ממשיך להיות מעורב – הופך למסייע הפעולה. כאשר המדריך סיים את החלק בו הוא משתלט, יחזיר מיד את האחריות לסטודנט.
- **תחקיר** – הסבר המדריך לסטודנט את הטעויות וכיצד יכלו למנוע אותם.
- ייעוץ עם המטופל מאפשרת לו להרגיש שליטה על הטיפול בו ומאפשרת לסטודנט להרגיש שליטה בגישה הטיפולית.

מתי להתערב

- כאשר התנהגות, אינטרקציה או חוסר כשירות מסכנים את המטופל בצורה ברורה.
- יש לקחת שליטה באופן רגוע ואסרטיבי לפני שנגרם נזק.
- יש להתייחס לסיטואציה בגישה ישירה תוך חוסר השפלה של הסטודנט או הרגשה של המטופל שמשוה לא בסדר.
- יש לבצע תחקיר בסוף הפעולה.
- על המדריך להתערב גם במצבים בהם הסטודנט לא מסוגל לבצע את הפעולה גם לאחר ניסיון הרגעה. על המדריך לדאוג לרווחתו, לברר את הסביבה ולמנוע זאת להבא.

הבטחת סיפוק צרכי המטופל – בטיחות, נוחות ופרטיות

- **פיתוח גמישות** בביצוע פעולות מתוכננות על מנת להתמודד עם מצבים לא צפויים. יש לאפשר לסטודנטים זמן נוסף לביצוע פעולה. יש לעודד שימוש בתוכנית גיבוי.
- **קביעת סדר עדיפויות** – מאפשר לסטודנט לזהות את הפעולות לביצוע ולתזמן אותם. בנוסף, מבססת את הציפיות מיום ההתנסות.
- יש להנחות את הסטודנטים לקחת בחשבון **תוכנית טיפולית רחבה** ולא רק אספקטים של פעולות סיעוד.
- יש להתאים **זמנים מחדש** על מנת לאפשר פעולות אחרות.
- יש לקחת **בחשבון ביקור רופאים** בזמן תכנון יומי.
- סטודנט נשאר בחדר גם אם רופא נכנס ומאפשר לו לשאול שאלות.
- יש לקחת במידת האפשר את **ההעדפות של המטופל** לגבי הטיפול בו. מאפשר חיזוק קשר ואמון בין המטופל לסטודנט.

- **מודעות לסדר יום מחלקתי** כולל זמני הפסקות של סטודנטים מאפשר לצוות הסטודנטים לעבוד בשיתוף פעולה. יש לוודא כי הסטודנטים לוקחים הפסקות על מנת לדאוג לרווחתם.
- **תיאום פעולות הלמידה** – תכנון פעולות מראש לכל יום של התנסות. יש צפייה מהסטודנטים לסיים את הטיפולים כולל הדיווחים ומסירת מידע לאחות אחראית עד סוף היום.

קידום אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה

ידע תיאורטי – נבנה בצורה היררכית ומתחלק לתחומי ידע:

- **זיכרון** – רכישת ידע רלוונטי לתחום הנלמד. התחום הקוגניטיבי הנמוך ביותר.
- **הבנה** – פירוש המידע הנלמד. יכולת הסטודנט לחזור על המידע במילים
- **יישום** – שימוש בידע הנרכש בהתמודד עם בעיות קונקרטיות.
- **ניתוח** – פירוק המידע למרכיבים על מנת להבין אותו טוב יותר. ישנה הסקת מסקנות וארגון.
- **סינתזה** – הסטודנט מייצר רעיון חדש של הידע מתוך גופי ידע קודמים.
- **הערכה** – דורש מהסטודנט להפעיל קריטריונים פנימיים מבוססי ערכים וחיצוניים אודות הידע.

שאלות שאלות – הגישה הנפוצה ביותר להתחלת תהליך האינטגרציה.

- הסטודנט נדרש לגשת למידע רלוונטי ואז להדגים את ההבנה לגבי הידע דרך תשובות לשאלות המדריך.
- השאלות צריכות להיות מעמיקות מעבר לרמת הזיכרון וההבנה על מנת לפתח מיומנויות אינטלקטואליות מסדר גבוה.
- תשאול שחושף את התהליך החשיבתי של המדריך – מאפשר פיתוח רמות קוגניטיביות גבוהות של הסטודנט.

סיפורי מקרה – מציגים סיטואציה אמיתית למטרת ניתוח.

- מעודד פיתוח מיומנויות אנליטיות, תובנה, יצירתיות ועידוד סטודנטים לנתח בעיות קליניות בלי חשש לפגיעה בבטיחות המטופל או בנחות שלו.
- **יתרון** – חשיפה של הסטודנטים לבעיות שכיחות בשטח. מאפשרת למדריך להבין את הידע הבסיסי והתהליך המחשבתי של הסטודנטים.
- **חסרון** – משך הזמן הנדרש להכנת החומרים המתאימים לחומר התיאורטי ומידת הרלוונטיות להתנסות הקלינית.

למידה מבוססת בעיות – מפתח סיטואציה בעייתית מורכבת עם מספר פתרונות פטונציאליים.

- בעיות מעוררות תובנות סביב אבחנה סיעודית על מנת לחקור את העקרונות הנלווים.
- הסטודנטים משתמשים במיומנויות כמו שיתוף פעולה, העלאת השערות, איסוף נתונים והערכות.

הצגת סמינר – הסטודנט מציג סיטואציה קלינית מול שאר חברי הקבוצה.

- הצגת הרקע והתיאוריה שהובילה להתערבויות שנקטו
- יש לאפשר לשאר הכיתה לשאול שאלות במטרה להפיק עוד מידע.
- מאפשר למידה אפקטיבית תוך הקשבה ושיתוף פעולה.
- מומלץ שהמדריך יוודא את אמינות המידע לפני הצגתו על מנת למנוע מבוכה ופגיעה בלמידה של שאר הסטודנטים.

סבב אחיות

- מאפשר לסטודנט לקבל מידע על המטופל על מנת להפחית רמת סטריס.
- יתרון – נוכחות המטופל שמאפשרת הדגמת ממצאי האומדן או טכניקות התערבות.
- מאפשר קבלת משוב מהמטופל.
- מאפשר לעשות שיקוף על אירועים, להתבסס על תיאוריות ולדון במקרים במטרה לקדם פתרון בעיות.

מטלה כתובה

- קביעת המטלות מראש לביצוע על ידי כל הסטודנטים.
- למדריך הקליני צריך להיות מידע לגבי המטלה, היעדים שלה והשפעת הציון על הציון הסופי.
- המדריך צריך לדעת את אורך המטלה, סגנון כתיבת המקורות, מועד הגשה והאם ניתן לאפשר לסטודנט שנכשל או לא הגיש בזמן לבצע שוב.
- בהיעדר הוראות המדריך מחליט על המטלה.
- **תוכנית טיפול גדולה**
 - סיפוק נתונים שמתארים את התגובה של המטופל להתערבות – שיקוף לתוצאות טיפוליות. אומדן מבוסס ראיות.
 - ניתוח לגבי כמה הקיפו את הבעיה ומה הגישות האלטרנטיביות. מאפשר לבחור גישה לטיפול.
 - הסבר תהליך קבלת ההחלטות בזמן קביעת האבחנות הסיעודיות, הבחירה והביצוע של ההתערבויות.
- **מטלת סינתזה** – לקיחת בעיה קלינית רחבה והדגמת הבנה וניתוח דרך סקירה של ספרות. שימוש באומדן מבוסס ראיות. דורשת מהסטודנט להגיע למסקנות מהמחקר.

- **מטלה המתמקדת בהתערבות סיעודית** – הצגת נתונים שתומכים בזיהוי הבעיה וזיהוי פרטים חשובים לגבי יישום ההתערבות.

שילוב של הנחיות מבוססות ראיות הדרכה

- יש לאפשר לסטודנט לגשת לעבודה טיפולית עם רוח של סקרנות שמטילה ספק בבסיס הטיפול הסיעודי.
- המדריך הקליני מביא דוגמאות לטיפולים שהיו מקובלים בעבר אך לא מקובלים כיום – עקב העלאת ספק.
- בסיטואציות בהן אין הנחיות מבוססות ראיות, המדריך יכול לעודד את הסטודנטים לחפש מחקרים בתחום בעזרת שאלות המבטאות את מהות הנושא הקליני שעולה בסיטואציה.

פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית ושיקוף

שיקוף – תהליך של חשיבה תוך הסתכלות אחורנית על התנסות במטרה להסיק משמעות חדשה.

חשיבה ביקורתית – העברה ויישום ידע ומיומנויות לסיטואציות חדשות. הסטודנט מתמודד עם חוסר וודאות ומטיל ספק בהנחות. משתמשים באומדן, אבחנה, תוכן, יסוד, הערכה חוזרת.

אינדיקציות לחשיבה ביקורתית בהקשר הסיעודי

- רוחב האומדן – טווח רחב של סימנים בביצוע אומדן.
- הטלת ספק בהנחות
- זיהוי סימנים – הרהור לגבי נתונים ודפוסים רלוונטים שעולים בסיטואציה
- מסגור בעיות – בחירה של בעיה פוטנציאלית אחת או יותר בהתבסס על נתונים שזוהו
- יישום – מותאם ידע ומיומנות
- הערכה – לגבי הצלחת ומידת ההתאמה של פתרון הבעיה.
- רפלקציה – ניתוח אנליטי והעברת ביקורת לגבי התהליך של פתרון הבעיה.
- **רפלקציה** – מעלה חוויות באופן יזום, מאפשרת לארגן ולהבין את הרעיונות והמידע החדש. מאפשר לסטודנט להוציא את הרגשות שלו בזמן הפעולה.

אסטרטגיות לקידום חשיבה ביקורתית ורפלקציה

- **דיבור והבהרת הדברים** – המדריך משתף לגבי תהליך החשיבה שלו ומאפשר לסטודנטים לזהות את הקשרים שהוא מבצע בניתוח הידע.
- **תשאול קוגניטיבי מסדר גבוה** – הסטודנט נותן משקל שווה לכל הנתונים בסיטואציה בשלב הטירון, אין העדפה.
 - יש להתמקד בשאלות הלמה – דורש מהסטודנט לנתח סיטואציה רלוונטית ולבצע סינתזה.
 - מיקוד בשאלות של אילו – מאתגר את הסטודנט לשקול תרחישים אלטרנטיביים חלופיים ומדגישות את הצורך להימנע מבחינה מוקדמת של הפתרון.
- **תחקיר** – הסטודנטים חולקים את התגובות האישיות שלהם בנוגע לחוויות בהתנסות, הם משתפים בפחדים והספקות ובכך מבינים שהרגשות שלהם אינם ייחודיים.
 - ביצוע בסוף יום התנסות או סימולציה.
 - יש לקדם ולהעריך את ביצועי הסטודנטים תוך העלאת מוטיבציה לחיפוש פתרונות חלופיים, יצירתיות ורפלקציה.
 - השיתוף מקדם תהליך של התמקדות במטופל וצרכיו.
- **כתיבת יומן** – כתיבה על חוויות שהתרחשו במהלך ההתנסות – רפלקציה. המשמעות שהסטודנט נותן להתרחשויות ולא תיעוד של האירוע.
 - מתן ציונים עלול לגרום לחשיבת יתר על הציפיות של המדריך ולהגיד את מה שהוא רוצה לשמוע.
 - ניתן לכוון בעזרת שאלות פתוחות או רשימת נושאים לדיון.
 - ניתן להוסיף ביטויים יצירתיים כמו שירה.
- **תיעוד תהליך** – הסטודנט מתאר סצנה מאינטרקציה עם מטופל ואת המטרות שלה.
 - כולל חילופי מילים ושפת גוף.
 - הסטודנט מנתח את האינטרקציה ומסכם מה למד וכיצד לתכנן להבא.
 - המדריך הקליני מבחין בניאנסים שהסטודנט לא רואה ובכך מרחיב את המודעות למורכבות התקשורת הטיפולית.

- **הערכה עצמית** – בחינת קבלת ההחלטות וההתנהגויות.

התחום הרגשי: קידום של אכפתיות בטיפול

הגדרה – התגובה הרגשית של הסטודנט מנחה אותו לשאול שאלות לגבי תגובות עתידיות לסיטואציות שונות המובילות לבחינת מערכת הערכים והגישות ביחס להתנהגות הטיפולית.

ערכי ליבה שמאפיינים אחות מקצועית – כבוד, יושרה, אוטונומיה, אהבת הזולת, צדק חברתי.

שאלות שמעודדות את הסטודנט להמשיך ולחקור את רגשותיו

- האם אתה יכול לתאר
- מה התרחש כאשר רגשות אלו התעוררו לראשונה.
- מה אתה חושב על רגשות אלה.

הבהרת ערכים – מצבים בהם הסטודנט אדיש ביחס לדילמה האתית עקב אי קליטה של הקונפליקטים. המדריך מעודד את הסטודנט לנסח ערכים ביחס לסיטואציה, להציע ערכים חלופיים ואז לאתגר את הסטודנט לחשוב עליהם והצדיק את ההבחירה שלו בערכים או לשנות אותם.

5 דרכים ללמוד דאגה

- **דוגמה אישית** – הדרך בה הצוות והמדריך דואגים למטופלים – משפיע על הסטודנט.
- **דוגמה שלילית** – התנהגות לא דואגת מעוררת התחייבות שלא להתנהג ככה.
- **דמיון** – לדמיין את עצמם או המשפחות שלהם בסיטואציה על מנת להבין את צרכי המטופל.
- **תחושה** – הבחנה בשינויים שמרגישים בגופם בתגובה לביטויים של חוסר נוחות או מצוקה מצד המטופל.
- **הבנייה** – ביסוס על ניסיון קודם וידע תיאורטי על מנת להבין את התנהגות המטופל.

הבטחת כשירות תרבותית בעבודה עם אוכלוסיות מטופלים מגוונות

- סטודנטים נוטים לא לשים לב לאספקטים תרבותיים, באחריותו של המדריך להסב את תשומת הלב לגורמים אלה המשפיעים על הטיפול, תהליך ההחלמה והבריאות לטווח ארוך.
- ישנה שונות ביחס לגיל וכן מעמד סוציואקונומי והגישה למשאבים בריאותיים.
- מטלה כתובה יכולה לעזור להבין את התרבות של המטופל.
- יש לעודד את הסטודנטים לנסח שאלות באופן חיובי המונע שיפוטיות כלפי המטופל.
- יש לבקש ממטופל לחזור על הדרכה על מנת לוודא שהבין ואף לשאול שאלות מכוונות.

פרק רביעי של סמית – מנהיגות חינוכית

מנהיגות אקדמית (academic leadership)

הגדרה – סיוע לאנשים בזיהוי, התעמתות ופתרון בעיות שדורשות הסתגלות למציאת משתנה שעדיין אין לה פתרון מקובל.

- הנכונות להתאים או לשנות ערכים והתנהגויות בסבבה האקדמית.
- הדרך הנפוצה ביותר לפתח מנהיגות היא חונכות לא פורמלית ולאחריה פיתוח מנהיגות פנימית.
- מנהיגות בסביבה אקדמית אינה פעולה של יחיד – יש צורך בשיתוף פעולה בין כל חברי הארגון.

תפקידי המנהיגות – ניהול צוותים ותוכניות.

אתגרים

- ריבוי תפקידים
- פיתוח מנהיגות
- היעדר תוכניות מסודרות להורשת התפקיד.

אומנות הסיעוד (art of nursing)

הגדרה – היכולת להעביר בצורה מילולית או לא מילולית דאגה, קשר בין אישי ונוכחות מרגיע אצל המטופל. שימוש יצירתי ומכוון ביכולות של העצמי תוך מיומנויות ומומחיות, להעביר רגש לאחר.

תרגול אומנות בסיעוד תוך סימולציה – מתן רקע לבובה והסבר על הצורך בביצוע המיומנות המתורגלת. ניתן להקליט את האינטרקציה על מנת לשקף לסטודנטים.

טכניקה נוספת לתרגול – תשאול הסטודנט כיצד הרגיש בסיטואציה.

רפלקציה עצמית – מאפשרת לסטודנט להבין את המקרה טוב יותר בהקשר מסוים. ניתן לבצע הערכה עצמית בעזרת יומן כתיבה שמתאר את המחשבות והרגשות שלהם.

מרכיבי הטיפול הסיעודי האומנותי לפי מטופלים

- נוכחות מתמדת
- להכיר את האחר
- אינטימיות בסבל
- התעמקות בפרטים
- מתן כבוד לגופה

תקשורת (communication)

הגדרה – התנהגות או תהליך של שימוש במילים, סימנים או התנהגויות על מנת להביע רעיונות ומחשבות או במטרה להעביר מידע.

תפקידי התקשורת – פיתוח מערכת יחסים עם מטופל ומשפחתו תוך סיפוק נוחות וכן העברת מידע לאנשי צוות רפואיים נוספים להבטחת טיפול בטיחותי.

עקרונות חשובים בפיתוח מיומנויות תקשורת

- ביסוס על חוזקות וניסיון חיים של הסטודנט
- למידת חשיבות התקשורת בסיעוד
- אתגרים העומדים בפני תקשורת יעילה.
- פיתוח קשר טיפולי תוך אמפתיה
- ניהול קונפליקטים
- מתן דגשים בתקשורת עם אוכלוסיות מיוחדות: זקנים, ילדים, ליקויים קוגניטיביים או מנטליים.
- מיומנויות צפייה והקשבה פעילה
- ידע ומיומנות בפיתוח תקשורת בין צוותית.

אסטרטגיות ללימוד תקשורת

- שימוש בסימולציות ומשחקי תפקידים. מאפשר סביבה בטוחה ולא מאיימת.

- הדגמה והצגה
- מידע כתוב
- דיונים קבוצתיים
- מתן משוב על מיומנות תקשורת ותפקוד.

אינטליגנציה רגשית (EI)

הגדרה – היכולת לתפוס ולהבין את הרגשות של העצמי ושל האחר ולהשתמש במידע זה בכדי להנחות את החשיבה והפעולות. אחות צריכה להבין את הצד שלה והצד של המטופל.

מודל היכולות – מזהה 4 מרכיבים של אינטליגנציה רגשית

- תפיסה של הרגש
- הנמקה של הרגש
- הבנה של הרגש
- התמודדות עם הרגש.

המודל התכונתי – מתמקד בתפיסה העצמית של האדם לגבי היכולת שלו לזהות, לאמוד ולשלוט ברגשות של העצמי, של האחר ושל הקבוצות.

המודל המשותף

הגדרה – מרכיבים רגשיים שנוצרים עם חוויות החיים ולא מלידה.

- **מודעות עצמית** – להיות עם תובנות כלפי הרגשות ולהבין איך הן משפיעות על האחר.
- **רגולציה עצמית** – היכולת לשלוט בדחפים ולא לשפוט במהירות עד שנאסף מספיק מידע. רגולציה גבוהה מאפשרת התמודדות טובה עם שינויים.
- **מוטיבציה** – הרצון ללמוד ולחפש אתגרים. אנשים עם מוטיבציה גבוהה מחפשים פתרונות לבעיות ומעלים את הציפיות באופן תמידי כלפי עצמם ואחרים.
- **מודעות חברתית** – היכולת להבין תחושות ורגשות של האחר לפני קבלת החלטה. אנשים אמפתיים הם בעלי מודעות ארגונית גבוהה.
- **ניהול מערכות יחסים** – היכולת לנהל וליצור מערכות יחסים עם אחרים.

העצמה (empowerment)

הגדרה – מרכיב בין אישי שכולל תהליכים קוגניטיביים ומוטיבציה כמו מציאת משמעות, מסוגלות עצמית והרגשת התרומה של העצמי לסביבת העבודה.

גורמים המשפיעים על התפתחות העצמה

- קבלת תחושת הערכה כחלק מהצוות
- מנחה תומך
- עבודה במקום עם אווירה חיובית
- גורמים חברתיים ופוליטיים.

השגת העצמה נובעת מכוח בלתי פורמלי ופורמלי.

בלתי פורמלי – נובע מיצירת קשרים בארגון.

פורמלי – ביצוע תפקיד שמספק אוטונומיה וגמישות שתומכים ברלוונטיות לארגון.

מעורבות (engagement)

הגדרה – הדרך שבה אנשים מרגישים מחוברים בצורה חזקה וחיובית.

מעורבות קהילתית – שימוש במשאבים מוסדיים על מנת לפתור אתגרים שעומדים בפני הקהילה דרך שיתוף פעולה.

יתרונות מעורבות גבוהה

- מאפשר קשר טוב יותר עם ההנהלה
- תחושת העצמה גבוהה
- יעילות
- התמודדות טובה יותר עם קבלת החלטות ופיתוח מקצועי
- שמירה על איזון בין החיים האישיים לעבודה.

גורמים המשפיעים על רמת מעורבות

- סביבת עבודה מעצימה ותמיכת מנהיגים
- צוות מספק מבחינה מספרית
- סביבה שמעריכה אוטונומיה, פיתוח מקצועי וקשרים קוליגיאליים.
- התגברות על מכשולים אישיים.
- מציאת משמעות בעבודה שהאדם עושה.

מנהיגות (leadership)

הגדרה – תהליך חברתי בו היחיד משפיע על התנהגויות האחרים מבלי להשתמש באיומים. היכולת לתאר חזון ולמקד יחידים לחזון זה תוך מעורבות, עידוד לעבודת צוות, מחויבות ויעילות.

סוגי מנהיגות

שם המנהיגות	קבלת החלטות עם הצוות	מטרה	חיפוש אשמים
דמוקרטית (DEMOCRATIC)	תקשורת פתוחה והשתתפות מלאה של הצוות בקבלת החלטות	שיפור תפקוד ואיכות המערכת	אין מקום לחיפוש אשמים.
משרתת (SERVANT)	לכל אנשי הצוות יש חלק בתהליך קבלת החלטות	להעלות מוטיבציה על ידי פיתוח המיומנויות היחיד והשפעה על אחרים.	אין מקום לחיפוש אשמים
חופשית פאסיבית (LAISSEZ-FAIRE)	מעט מההחלטות מתקיימות. המנהיג מספק מעט השגחה או הכוונה. החלטה לגמרי של הצוות.	הכשרת מנהיגים חדשים עקב חוסר ניסיון	-
סמכותית (AUTOCRATIC)	המנהיג מקבל את כל ההחלטות ללא התחשבות בצוות. ידע מהווה כוח.	הטמעת נהלים ופרוצדורות. לא מאפשר עבודת צוות.	מערכת של עונשים בעזרתם אוכפים את כללי הארגון. אין סובלנות לשגיאות.
עסקת חליפין (TRANSACTIONAL)	יש תלות הדדית בין העובדים למנהיג, תורמים אחד לשני.	התמקדות בהשלמת המטלה והיענות העובדים.	מתן עונשים ותגמולים ארגוניים לפי ביצועי העובדים.
מנהיגות מהפכנית (TRANSFORMATIONAL) <u>הכי יעילה!</u>	המנהיגים יוצרים ומשמרים שינויים משמעותיים בביצועים, במוטיבציה ובמסירות העובדים על ידי חזון ומטרה משותפת.	- <u>השפעה דרך הערצה</u> – בניית אמון וביטחון מתוך כבוד והערצה. - <u>מוטיבציה מעוררת השראה</u> – יצירת התלהבות לקראת חזון משכנע של העתיד. - <u>קידום שינוי</u> על ידי הערכה מחודשת וערעור לגבי המצב הקיים. - <u>הכרה</u> בכך שלכל אחד יש צרכים, יכולות ומטרות ייחודיות.	אין

התנהגויות ליבה של מנהיג

- **להיות מודל** – המנהיג צריך להוות דוגמה ולהתנהג בצורה המותאמת לערכים המשותפים של הקבוצה.
- **לתת השראה עבור החזון המשותף** – תקשור נקודת מבט ייחודית עבור העתיד.
- **לאתגר את התהליך** – שאיפה למציאות.
- **לאפשר לאחרים לפעול** – קידום מטרות משותפות, חיפוש אחר פתרונות חדשים ובניית אמון.
- **לעודד עבודה מתוך הלב** – פיתוח בטחון עצמי דרך הצבת ציפיות גבוהות ומתן תגמול והוכרה לביצועי היחיד.

פיתוח מנהיגות

הגדרה – תהליך של זיהוי מטרות, מתן מוטיבציה לאחרים לפעול ומתן תמיכה להשגת מטרות משותפות. ישנה התמקדות באינטליגנציה רגשית ופיתוח מנהיגות אתית וערכית.

הנחייה (MENTORING)

הגדרה – תהליך פורמלי או בלתי פורמלי של מתן הנחייה על ידי אדם בעל ניסיון גדול ליחיד או קבוצה עם פחות ניסיון במטרה להכשירם.

יתרונות

- תמיכה והכוונה מצד המונחים.
- מאפשר תקשורת פתוחה
- מאפשר יצירת קשר בין המנחה למונחה.
- מגבירה שביעות רצון מהעבודה
- מפחיתה רמות סטרס
- מאפשרת לפתח כישורים חדשים.

חסרון – חוסר זמן לבצע פעולות משמעותיות עם המונחים.

מרכיבי מפתח להנחייה יעילה

- תקשורת פתוחה
- הצבת מטרות
- תשוקה והשראה
- דוגמה אישית
- כבוד ואמון הדדי.

הנחייה: קשר בין מנחה למונחה בחסותו

ארבעת התוצאות התפקודיות של הנחייה בחינוך בסיעוד

- היכרות עם תפקידי סגל ההוראה
- התחברות בקהילה האקדמית
- פיתוח מיומנויות לימוד, מחקר ושירות
- קידום הצמיחה של המנהיגים העתידיים בסיעוד ובחינוך בסיעוד.

מודל של מצוינות לבניית תוכניות הנחייה עבור המונחים בסיעוד

- חלוקת זוגות של מנחה מונחה בצורה נכונה ומתאימה
- ביסוס באופן ברור את המטרות והיעדים של ההנחייה
- ביסוס הקשר בין המנחה למונחה.
- סנגור ולתת הכוונה למונחה
- שילוב המנוחה בתרבות האקדמית
- ניווד המשאבים.

הנחייה: מעבר לתפקיד המתקדם

מודלים שונים

- **לפי מודל השוליה** – המנחה משגיח ומנחה את המונחה
- **לפי מודל הכשירות** – המנחה מנטר ומעריך את ביצועי המונחה שמוגדרות מראש
- **לפי המודל הרפלקטיבי** – המנחה מכון את המונחה לפיתוח זהות מקצועית.

מרכיבים המושפעים מהקשר שנוצר מתהליך ההנחייה

- איכות הטיפול
- פרדוקטיביות
- שביעות רצון מעבודה
- משך השהות בתפקיד

תפקיד המדריך

הגדרה – רצף של אינטרקציות בין המדריך לסטודנט שמתחילות להתרחש בסיטואציות לימודיות שנשלטות על ידי המדריך ובהמשך מתקדמות לקשר קולגיאלי.

עקרונות מנחים לקשר המתפתח עם הסטודנטים

- **שמירה על גבולות תוך קידום אמון והפגנת אכפתיות ודאגה כלפי הסטודנטים** – לא חברותי מידי אך גם לא מתרחק.
- **המדריך צריך להיות בתוך התפקיד ולא לשחק אותו** – משחק גורם לריחוק הסטודנטים ומפריע לפיתוח קשרים הדדיים של כבוד ושיתוף פעולה.
- **לשמש מודל לחיקוי בסייעוד** – כמו בקשר בין אחות למטופל, שניהם מכבדים את הייחודיות של כל אחד, מצעבים אינטרקציה תוך דאגה לאחר, השגת מטרות משותפות והצבת גבולות.

המדריך הקליני כמחנך (TEACHER)

- מספק מסגרת ומכוון את התנהגות הסטודנטים
- מעצב חוויות לימודיות להשגת מטרות ויעדים לימודיים.
- מדגים את התוכן והמיומנויות הרלוונטיות ודן באלטרנטיבות שונות לגישות טיפול.
- כאשר הסטודנט יוצר מספיק תחושת ביטחון, המדריך הופך למאמן.

המדריך הקליני כמאמן (COACH)

- מאפשר לסטודנט לפעול בחופשיות במסגרת הכללית כולל אלתור.
- במידה וסטודנט מהסס בביצוע פעוטלה שכבר בוצעה, על המדריך לספק רמזים מתאימים שיכוונו את הסטודנט ולא לבצע למידה חוזרת.
- צריך להביע אמון ביכולות הסטודנט ולהטמיע בקרב הסטודנטים צפייה להצלחה.
- בהמשך יהפוך ל PRECEPTOR שם יבצע הקשבה זהירה ויתערב רק במקרים בהם יש סיכון למטופל.

המדריך הקליני כמשגיח (SUPERVISOR)

- השגחה על הסטודנטים בזמן ביצוע פעולה.
- ביצוע פעולות בחשאי יוצרת תחושה של חוסר אמון ומתח לעומת מדריך שמתייחס בחום למטופל ומאפשר לסטודנט לשאול שאלות או לבקש הנחייה במשימה.
- שוטר בטיחות במצבים שעלולים לפגוע בטיחות המטופל.
- מומלץ לדבר בצורה גלויה על טעויות ומניעתן – המדריך נתפס כתומך.
- במצב בו המדריך מתעקש להיות עם סטודנטים בזמן שהם מבצעים את הפעולה יוצר חוסר אמון לגבי היכולות שלהם.
- תפקיד משמעותי ששומר על בטיחות המטופל וכבוד הסטודנט. יוצר הוגנות וכבוד.
- התנהגות סטודנט בלתי מקובלת – שיחה עם הסטודנט במקום עם פרטיות.
- סטודנט פועל בצורה לא בטיחותית – המדריך יסיים את הפעולה מבלי להבהיל את המטופל, תוך שמירה על כבוד הסטודנט. לדוגמה: תן לי לעזור לך לסיים את הפעולה.

המדריך הקליני כמעריך (EVALUATOR)

- מעמיד את ביצועי הסטודנטים כנגד ציפיות מוגדרות של הקורס
- **הערכה מעצבת** – מספק משוב לכל אורך התהליך המקדם את הסטודנטים לשיפור הביצועים והשגת יעדי הקורס.
- סטודנטים שלא מקבלים משוב מסוג זה, נוטים להרגיש חוסר ביטחון וחוששים להיות מעורבים בחוויות חדשות.
- **הערכה מסכמת** – שיפוט לגבי נתונים שנאספו במהלך ההתנסות, הקובעים את ציונו של הסטודנט. מספקת את רמת ההצלחה של הסטודנט. סטודנטים עם משוב רציף לא יפתעו מההערכה.

המדריך הקליני כאח (NURSE)

- כאשר המדריך מציג את עצמו כאח מיומן – הוא תומך הסטודנט המתפקד כאח מול המטופל.
- כמודל לחיקוי המדריך יכול להדגים אספקטים שקשה להסבירם באופן מילולי כמו הבעת דאגה.
- בזמן ליווי סטודנט הממוקד במטרה, המדריך יכול להדגים אספקטים בתפקיד האחות שעדיין לא שולבו בצורה יעילה בביצועי הסטודנט כמו מתן הסבר לפעולה.
- המדריך הקליני צריך לראות את עצמו קולגה עתידית לסטודנט ולהשתדל להביע אספקטים מהנים מהקריירה המקצועית.
- יש להימנע מיצירת קשרים של מנטור עם הסטודנטים שלו – עלול להיתפס כהעדפת סטודנט מסוים על פני אחר בתוך קבוצת מודרכים.

הבעת דאגה

הגדרה – נוכחות אותנטית וחיבור עם האחר המתאפיין בדפוסים של עזרה ואפשר.

אינטרקציה דואגת בין סטודנטים לסגל ההוראה לפי HANSON

- הכרה – הקשבה אמיתית לסטודנט בלי הסחות דעת, זיהוי וסיפוק צרכי הסטודנט.
- חיבור – יצירת קשר בין אישי אותנטי, זיהוי ותגובה לשאלות ולהודות בטעות (מדריכים גם טועים).
- חיזוק – מתן חיזוק חיובי ועידוד, הבעת רצון אמיתי שהסטודנט יצליח.

פעולות שהמדריך הדואג מבצע

- מקשיב מבלי לשפוט ונותן תחושה של קבלה
- מכיר בחיים האישיים של הסטודנט ולא רק בתפקידו כסטודנט
- מביע גמישות, הוגנות וכנות
- מיומן ביצירת קשרים בין אישיים וכן מיומן בללמד.
- נותן מידע, מציע הצעות, עוזר לפתור בעיות ומבטיח התנסות חיובית.

תוצאה עבור הסטודנט בהקשר הדואג

- תחושה של נוחות, ביטחון, כשירות ומתן מוטיבציה להמשך, להשיג יותר וללמוד יותר.
- מרגיש שעשה בחירה נכונה במקצוע
- הסטודנט לומד לדאוג לאחרים עקב הדאגה של המדריך אליו.
- מחזקת מוטיבציה מכיוון שמחזקת את תחושת הערך והפוטנציאל של היחיד.

התנהגות דואגת לפי POORMAN

- להיות עם הסטודנט – מתן תמיכה ועידוד. הסטודנט צמא ליחס ונוכחות המדריך.
- חזרות – חזרה על מידע חשוב ומתן דגש על הידע הרלוונטי
- לגשת – המדריך הקליני יוזם וניגש לסטודנט במטרה לעזור.

התנהגות מפריעה לסטודנטים לפי POORMAN

- חוסר דאגה – חוסר עניין בללמד סטודנט עקב חוסר סבלנות.
- שליטה – מדריך שמעמיד את הסטודנטים בעמדה נחותה משלו. יוצא מאבק כוחות ולא מייצר שיתוף פעולה.
- ריחוף – תחושה של חוסר אמון בסטודנט.
- תיעדוף – של סטודנט מסוים על אחרים.

מרכיבים שתורמים להצלחת המדריך בהעברת תחושת דאגה

- להיות בתוך התפקיד במקום לשחק – להיות הכי אותנטי, מדריך לא מושלם.
- לדעת את החומר – העברת תחושת ביטחון ונוחות בסביבה הקלינית.
- להעריך אנשים – מדריך שלא פיתח יכולת הבעת דאגה, לא יוכל לפתח אספקט זה.

הבעת התלהבות (ENTHUSIASM)

- כאשר המדריך הקליני מציב סטנדרטים גבוהים ודורש לקיחת אחריות על ביצועים אלה, הוא מעביר את משמעות עבודת הסיעוד.
- בעת הצגת הפעולות שיבוצעו במהלך יום ההתנסו, המדריך יכול להצביע על ההזדמנויות הייחודיות הטמונות במשימה ובכך להראות התלהבות.
- מרבית הסטודנטים מתרגשים לקראת ביצוע פעולה בשטח אך חוששים להגיב כי מבחינת החברה זה יחשב כ"לא קול", כאשר המדריך מתלהב הוא מעודד ומעורר השראה בסטודנטים.
- מדריך קליני שמביע שביעות רצון והגשמה עצמית מאשר בכך את בחירת הסטודנטים להיות במקצוע זה.
- ישנו ערך רב לשימוש בהומור להקלה על סטס, לרומם את הצוות ולגרום לרוגע וביטחון בקרב המטופלים.

אסטרטגיות לתקשורת

הצבת מטרות (SETTING GOALS)

- משקפות את ציפיות ההמדריך מהסטודנטים
- יש להתייחס למטרות הטיפוליות ומטרות הסטודנטים
- יש להגדיר מטרות כלליות (בטיחות וסודיות) וספציפיות לכל מטופל.

- המדריך הקליני צריך לספק ציוני דרך המשמשים כתזכורת לביצוע אומדן ההתקדמות בדרך להשגת מטרות. מבהיר את המטלה וכיצד מבצעים אותה.
- יש להגדיר מטרות לטווח ארוך ולטווח קצר.
- תחושת התקדמות להשגת מטרות מעלה מוטיבציה ותורמת למעורבות לצורך השגת שליטה.

הבהרת ערכים

- המדריך הקליני מסביר כיצד הערכים שלו משפיעים על דרך מתן טיפול.
- הסטודנטים עדיין לא מסוגלים להבין מה הערכים שעומדים בבסיס הגישות הטיפוליות השונות והם צריכים עזרה לבצע רפלקציה על טיפול מבוסס ערכים.

מתן מוטיבציה לביצועים

- קידום מעורבות נלהבת של הסטודנטים באמצעות מתן הסבר על חשיבות הפעולה וכיצד תורמת לעבודה הסיעודית.

מתן שבח (PRAISING)

- מתן משוב חיובי בהערכה מעצבת מעלה את המוטיבציה.
- חשוב לא לשבח את הסטודנט באופן שאינו מותאם.
- על המדריך הקליני לזהות ביצועים מוצלחים ואת ההשלכות שלהם על המטופל.
- מתן שבחים עוזרת להקטין את תחושת רכבת ההרים – מקבל שבחים ביום אחד והערות ביום אחר.

מתן משוב מתקן

- מחזק את ההתנהגות, התחושה הפיזית, האינטלקטואלית והרגשית שמלווה את ההתנהגות.
- ככל שהסטודנט קשוב לאלמנטים שמפריעים להצלחה, הוא מסוגל לשפר את הביצועים שלו.
- יש להתמקד בהתנהגות והשלכותיה בעת מתן משוב.
- יש להסביר מה לא נכון, מדוע וכיצד ניתן לתקן.
- חשוב להצביע גם על האספקטים הנכונים בביצוע שלהם.

מניעת טיפול לא בטיחותי

- החשש מלטעות מפתח חרדה ולחץ בקרב סטודנטים המתחילים והמתקדמים.
- **סיפורי מלחמה** – דרך לזהות מקורות פוטנציאליים לטעויות ולחשף בפני הסטודנטים סימני אזהרה.
 - מתן הכרות לכך שאפשר לטעות
 - מתן דוגמאות מוחשיות לסוגי טעויות שונים שאפשר להיות מעורבים בהן.
 - מתן כללים למניעת טעויות שניתן ליישם
 - מדגימים כיצד ניתן ללמוד מטעויות.

סימני אזהרה בנוגע למתן טיפול בטוח:

- לא ניתן לסמוך על סטודנט שיבקש גיבוי או עזרה
- סטודנט לחוץ
- סטודנט שמאחר להתנסות
- סטודנט שניגש ללא ביטחון.

סימני אזהרה שמצביעים על סכנה

- הסטודנט אינו יודע לזהות מתי הטיפול הושלם ואינו מזהה חסרים בטיפול
- מתקשה בקביעת סדר עדיפויות וארגון פעולות טיפול
- הביצועים אינם עקביים
- לא ניתן לסמוך על הסטודנט שידווח על נתונים חשובים
- הסטודנט לא יודע לבקש עזרה
- הסטודנט לא מדווח על טעויות.

תיאור ליקויים בביצוע

- שיחה עם סטודנט שלא עומד בציפיות תתסצע באופן פרטני.
- יש לציין את הליקויים לפי חומרתם, שהכי חמור ראשון.
- יש להתמקד בדפוס התנהגות והשלכותיה. ולא בסטודנט ובחסרונותיו.

- אין לשאול את הסטודנט מדוע ביצע אלא מה ביצע ומה הפריע לו.
- במידה והסטודנט מסוגל לתקשר בעיה שמפריע לו, יש לעזור לו בפנייה לעזרה מקצועית או הפסקת לימודים.
- במידה ולא נמצא גורם חיצוני משמעותי שדורש טיפול, יש לבנות עם הסטודנט תוכנית שתעזור לו להשתפר כמו לתת מטלה פחות מורכבת.

ענישה

- יש להעניש בצורה מבודדת ובאופן פרטני.
- יש להזכיר אירועים דומים או זהים – לדוגמה סטודנט שמאחר הרבה פעמים.
- חשוב להעניש התנהגויות דומות שנצפות מהסטודנטים אלא אם כן יש משהו שונה בין שני האירועים – לדוגמה דיווח על איחור.
- ענישה קולקטיבית – במידה וכל הקבוצה פעולת בדפוס מסוים. יש לבצע בתחילת ההתנסות על מנת להבהיר את ציפיות המדריך הקליני והסטנדרטים המקובלים לביצוע.

הכשלת סטודנט

- אינו אמור להפתיע אם קיבל משוב מותאם וייעוץ מתאים במהלך ההתנסות.
- יש להציע לסטודנט אפשרות לעבור על הנתונים שנאספו לגביו
- יש לעבור עם הסטודנט על הצעדים שיכול לנקוט במידה וירצה לערער.

הרחקת הסטודנט מהתנסות

- התנהגות שמהווה סכנה עבור המטופל, הסטודנט או אחרים הנמצאים בסביבה הקלינית.
- סטודנט שמגיע לא מוכן להתנסות – יש לשלוח אותו לספרייה במשך שעה להתכונן ולא לשלוח לביתו.
- כאשר המדריך הקליני לא מוסגל להתמודד עם הסכנה הנשקפת, הסטודנט יידרש לעזוב את סביבת ההתנסות. שימוש בסמים או אלכוהול, אלימות.
- יש ליידע את הצוות ואת הסטודנטים האחרים על מנת לתכנן בהתאם.
- יש לדווח בהקדם לרכז ההתנסות, לתאר בקצרה את המקרה ואת הצעדים שנקטו על מנת להגן על המעורבים במקרה.

תגובה לסטור של סטודנטים

- הגדרה של סטור – חוויות הנתפסות כמאתגרות אך עם פוטנציאל לצמיחה או רווח וחוויות הנתפסות כמאיימות עם פוטנציאל לנזק. חרדה מפריע לעיבוד מידע, יש לבקש מהסטודנט משוב בכדי לוודא שהוא הבין והפנים.

גורמים לסטור בקרב סטודנטים

- הסביבה הקלינית היא סביבה לא צפויה הכוללת חוויות ייחודיות שלא ניתן לצפות להן מראש.
- ידע ותרגול לא מספק
- מראות מביכים
- השגחה צמודה של המדריך הקליני
- משאבים לא מספיקים של בית החולים
- גרימת כאב וסבל
- קונפליקטים בין הנלמד למציאות בשטח.
- דרישות הקשורות במתן טיפול.

- גישה להפחתת סטור – לעודד את הסטודנט להסתכל על המצב המאיים שאתגר שהוא מסוגל להתמודד איתו תוך הבנת המקור שלו ופיתוח צעדים בשיתוף פעולה עם המדריך להשגת הצלחה.

הנחיות להתערבות כאשר הסטור משתק את הסטודנט

- להכיר בצלקות פסיכולוגיות שלא החלימו ועלולות לגרום לכאב
- לאמוד סטודנטים שחווים סטור פסיכולוגי
- לעודד שיתוף במחשבות ורגשות
- לבצע תחקיר לסטודנטים לאחר סיטואציה סטרסוגנית.
- לעודד את הסטודנטים לקחת הפסקות לאחר סטור.
- לעודד את הסטודנטים להשתתף בפעילות לשחרור סטור
- להפנות סטודנטים שנראים במצוקה עם רמות גבוהות של סטור לייעוץ מקצועי.

מתן עזרה לסטודנטים בהתמודדות עם...

3 עקרונות לביצוע שיקוף לדרך בה המדריך מתמודד עם אספקטים קשים בסיעוד

- **אמפתיה** – היכולת להשתתף ברגשות האחר, להיכנס לנעליו. מסוגלות לקדם נוכחות ואיכות חיים של האחר. הסכנה – אחות מוצפת רגשית.
- **הצבת גבולות** – דרך להגן מפני הצפה רגשית. שמירה על מודעות לתפקידה כאחות.
- **אינטלקטואליזציה** – מנגנון התמודדות שתומך בהצבת גבולות. הבנה לגבי האופי והסיבות לרגשות המטופל וכך נוכחות תומכת בסטודנט עד שמרגיש מספיק עצמאי.

אמירות מיניות או גזעניות מצד המטופל

- הסטודנט שנמצא כקורבן לאמירות אלה צריך לקבל תמיכה לגבי תגובתו וכן ייעוץ לגבי המחויבויות שלו כמטפל לא לרדת לרמה של המטופל.
- יש לאפשר לו להביע את רגשותיו בתגובה לאירוע ולתת זמן לאסוף את עצמו רגשית לפני חזרה לשגרה.

לקראת המוות ומוות

- ידע תיאורטי עוזר לסטודנט להבין את תגובת המטופל ומשפחתו למוות מתקרב אך לא מספק כלים להתמודדות עם הסיטואציה
- עידוד הסטודנט לחשוב מה היה רוצה לקבל במצב כזה, בנוסף עם ניסיון המדריך עם מוות, יכולים לעזור לסטודנט לגלות גישות יעילות לטיפול.
- יש לבצע רפלקציה לאחר אירוע ראשוני של פטירת מטופל
- התגובה הראשונית יכולה להיות חשש כי ביצע טעות שגרמה לזירוז המוות. יש לפתור חששות אלה יחד עם הסטודנט מכיוון שנדיר שזו הסיבה למוות.
- איסוף נתונים אודות האירועים סביב מוות המטופל מאפשרת לסטודנט לבצע אינטגרציה משמעותית לעבודת הסיעוד שלהם.

דפורמציות, פצעים ושינויים נוספים בשלמות הגוף

- יש להנחות את הסטודנטים לקראת מה הם צפויים לראות בזמן טיפול בפצעים אלה. לדייק בפרטים כולל ריחות ומראות.
- הסטודנטים צריכים עזרה בכדי להתגבר על הפחד בזמן כניסה לחדר המטופל ובזמן הטיפול בו.
- הסטודנטים צריכים עזרה בכדי לשלוט בביטויים הבלתי מילוליים של הדחייה.
- ניתן להדריך סטודנט להתמקד בעיני המטופל ולא בדפורמציה.
- יש לעודד להתחיל בדיאלוג שהופך את המטופל לאנושי יותר.
- יש לספק לסטודנט דרך לסמן למדריך שהוא זקוק לצאת מהחדר. יש להמשיך את הטיפול המטופל ולעודד את הסטודנט לחזור כשהוא מוכן.
- חשוב שהסטודנט לא יטוש את המטופל וימשיך לטפל בו לטובת המטופל והביטחון העצמי של הסטודנט.

מיניות של מטופל

- **כאשר פגיעה בתפקוד המיני** היא בעיה עבור המטופל, הסטודנט יצטרך עזרה בבניית תוכנית לתקשורת עם המטופל שיאפשר להעלות חששות ויספק מידע למטופל.
- מתן טיפול בצורה עובדתית ושמירה על תדמית מקצועית – הגישה המתאימה כאשר מבצעים טיפול אינטימי.
- בזמן שיש **סטודנטים גברים**, יש לזהות פוטנציאל למטופלות שיסרבו לטיפולים אינטימיים. ניתן להפחית זאת על ידי הדגשת המקצועיות והצעה להיות נוכח בחדר בזמן הפעולה.
- **במקרה של מחלות מין** – יש לבצע חזרה על הבסיס הרעיוני של אמצעי הזהירות האוניברסליים שמניחה שכל אחד יכול להיות נשא או שמחלות כאלה מועברות גם בדם.
- **התייחסות מינית של מטופל לסטודנט** – המדריך צריך להיות מודע לפוטנציאל התנהגות כזאת מצד המטופל ולעדכן את הסטודנטים מראש. מאפשרת לסטודנט להציב גבולות ולהגיד למטופל כי זו התנהגות לא מתאימה.

פגיעה מצד רופא או איש צוות

- הצוות נוטה להוציא עצבים על הסטודנטים מכיוון שהם בתחתית השרשרת.
- יש לחזק את הצורך העיקרי של המטופל בקרב הסטודנטים ולהזכיר לגבי הזכות והחובה שלהם להיות מעורבים בטיפול

שמירה על קשרים עם הצוות

- המומחיות הקלינית של המדריך מהווה נכס גדול בקשרים עם צוות המחלקה. הצוות פחות מודאג לגבי רמת הדיוק בה הסטודנטים מבצעים את הפעולות כי הם סומכים על המדריך.
- המדריך צריך לעודד את הצוות וליידע אותו – מאפשר שיפור איכות טיפול ותגובה לחששות הצוות.

- המדריך הקליני יכול לעזור כתוספת לצוות אך לסרב בעדינות מלהיות משובץ למטופלים.

שליטה ברגשות בהקשר של המדריך

- תפקיד המדריך מטבעו סטרסווגני – צריך למלא את דרישות הסטודנטים, המטופלים והצוות.
- על המדריך להכיר את הצרכים הסיעודיים של כל מטופל ולהיות מוכן להתערב ולהשלים טיפול כשצריך.
- המדריך הקליני צריך להיות ערני לבעיות פוטנציאליות ולספק הדרכה לסטודנטים.
- להפגין רוגע ולהפגין מקצועיות.
- המדריך צריך לשלוט בחרדה שהוא מרגיש מכיוון שהיא מדבקת לסטודנטים. הוא צריך להימנע מביטויים של כעס ותסכול.
- על מנת לשלוט ברגשות המדריך הקליני צריך לפתח הרגל של רפקלציה לפני תגובה – לספור עד 10 לפני שאומרים או עושים משהו.

סמית – משוב והערכה

כישלון בהתנסות

הגדרה – מתרחש כאשר אומדן מבוסס ראיות ותהליכי הערכה מצביעים על התנהגות מסוכנת שסטודנט ביצע. הסטודנטים מקבלים הערכה לאורך כל ההתנסות שאומרת במה צריך לשפר.

התנהגויות שגורמים להכשלת סטודנט

- חסרים משמעותיים בידע
- יכולות פסיכומטריות מתחת למצופה ומיומנויות בין אישיות לא מתאימות
- חוסר מוטיבציה
- פעולות שמסכנות את המטופל
- התנהלות לא אתית או לא מקצועית
- כישלון לזהות או לחפש אחר עזרה כאשר יש חסרים בידע
- הפרת נהלים
- חוסר יכולת ליישם תיאוריה לפרקטיקה
- תיעוד שקרי או מזויף.
- סטודנט שלא מסוגל לשנות את התנהגותו למרות הערכות חוזרות.

סיבות להיסוס בהכשלת סטודנטים בקרב מדריכים

- חוסר התכוננות
- הפחד מתהליך הערעור
- הזמן הנדרש להשלמת הטפסים הקשורים לעניין
- הפחד להיות האיש הרע
- הציפייה של מוסד הלימודים שהסטודנטים יעברו בהצלחה
- הפחד שיאשימו את כישורי המדריך כגורם לכישלון
- הפחד לפגוע כלכלית בסטודנט
- הכישלון יגרום לסילוק הסטודנט מתוכנית הלימודים בסיעוד.

תמיכה אדמיניסטרטיבית

- מאפשרת הבנה של חשיבות תפקיד המדריך כשומר סף של המקצוע.
- מאפשרת דוגמה אישית לאחריות ואחריותיות.
- הבנה של המחויבות האתית והחוקית בקבלת ההחלטה להכשיל סטודנט.

הערכה קלינית

הגדרה – תהליך בו המדריך מעריך את ביצועי הסטודנט שהתנסה במחלקה מסוימת תוך שימוש בקריטריונים מוגדרים. תהליך סובייקטיבי המושפע מגישות של סגל ההוראה והסטודנטים.

תחומי הלמידה – קוגניטיבי, רגשי ופסיכומטורי.

מטרה – להבטיח שהסטודנט נותן טיפול בטיחותי ובסטנדרט גבוה. מצופה מהסטודנט לנתח מצבים קליניים מורכבים, להפגין יכולת פתרון בעיות ולהשתמש בתקשורת יעילה עם המטופלים והצוות.

היכרות עם הסטודנט מאפשרת הערכה אמינה ותקפה.

כלים מובנים להעריך התנהגות ולמידה

- הסתכלות בהתנהגות הסטודנט – הכי שכיחה.
- הגשת עבודות כתובות
- הערכה של השתתפות בדיונים קליניים.

סוגי הערכה

- **בונה** – הסטודנט מקבל הערכה במהלך ההתנסות לגבי החוזקות והחולשות שלו. יש לאפשר לסטודנט לתת משוב על ההתנסות הקלינית
- **הערכה מסכמת** – קובעת אם הסטודנט השיג את יעדי הלמידה והאם נחשב למטפל בטוח וכשיר.

נושא	הגדרה	בונה	מסכמת
כשירויות	היכולת לבצע מיומנות או התנהגות בהתאם לסטנדרט שמבטיח בטיחות ומונע נזק.	ישנו זמן מוגדר שמוקצב ללמידת מיומנויות ושילוב ביצוע הערכה בונה לביצוע מולצח של מיומנויות	לתת ציון המעיד אם הושגה הכשירות הקלינית או לא
יעדים לעומת תוצאות	לכל קורס יש יעדים שהסטודנט צריך לעמוד בהם. התוצאות מעידות על השגת יעדי הסטודנט.	לפי ביצועי הסטודנט להשגת יעדי הקורס.	תוצאות התוכנית מספקות הערכה מסכמת אודות התוכנית.
הערכת תוכנית לימוד לסייעוד לפי יעדים מול תוצאות	- אחוז הסטודנטים שעוברים את מבחן הרישוי בהצלחה בפעם הראשונה – מעיד על כמה התוכנית מכינה את הסטודנטים - אחוזי עזיבה וסיום תוכנית – מעיד על כמה התוכנית מכינה את הסטודנטים לעמוד ביעדי הקורסים ובתוצאות התוכנית - השפעה של סימולציות על הצלחת הסטודנטים בהשגת יעדים ותוצאות – מכין את הסטודנט לקראת תפקיד האחות ומשפר ציונים.		
סטודנטים	הערכה בשטח תוך תצפיות בסטודנטים וכן מתן ציון.	הערכה עצמית – רפלקציה. מסייע לסטודנט לפתח הרגלים שישפרו אותו מבחינה מקצועית.	שיטת OSCE – מאפשרת אובייקטיביות ואמינות. הפקת סיכום אובייקטיבי ללא הטיות דרך הסתכלות על ביצועי הסטודנט בסביבה מובנית (סימולציות)

אינפלציה של ציונים

הגדרה – עלייה בציונים של הסטודנטים בלי הוכחה לשיפור ביכולות.

מטרת הציון – לספק לסטודנט מידע לגבי יכולתיו להשיג את הידע הנדרש בסייעוד ולגבי הצלחותיו ביישום הידע לפרקטיקה.

היפר אינפלציה – גורמת לסטודנט לתפוס את הידע ויכולתיו גבוהות מהמציאות, דבר המסכן את המטופל.

סיבות להיפר אינפלציה

- **התמקדות בהשגת ציונים גבוהים** במקום בלמידה בקרב סטודנטים.
- מתן ציון גבוה שווה **הערכות טובות יותר** מהסטודנט לסגל ההוראה.
- **חשש מפני הליך ערעור** וחוסר רצון להתמודד איתו
- **היעזרות בסגל הוראה העובד במשרה חלקית** כמדריכים קליניים – אין מספיק ניסיון, ידע וביטחון שנדרש.
- **חוסר רצון להכשיל סטודנטים** לסייעוד (במיוחד בשנה הראשונה) – מאפשרים הזדמנות שנייה
- **מורכבות הערכים המקצועיים** והשפעת הדרישות הרגולטריות המרובות.

דרכי התמודדות

- **פיתוח כישורי הערכה** בקרב סגל ההוראה
- שימוש **בכלים מובנים תקפים ואמינים** להערכה
- **הערכה מחדש** של נהלי האוניברסיטה
- הגדרה מדויקת של **קריטריונים לגבי תוצאות רצויות** מההתנסות
- מתן ציון עובר או נכשל **ולא ציון מספרי**.

מתן ציון

הגדרה – מתן רמת זכאות לעבודת הסטודנט. יכולה להיות אות, מספר או עובר/נכשל ומייצג את מאמצי ויכולות הסטודנט בביצוע מטלה או קורס. מתן מספר או אות מאפשר השוואה.

נושאי מפתח סביב מתן ציונים

- אינפלציה של ציונים (הוסבר למעלה)
- פערים בין ציונים תיאורטיים לקליניים

- האתגר הקשור במתן ציון נכשל בקורסים קליניים.

פערים בין ציונים בקורסים תיאורטיים לקליניים

- בקורסים הקליניים גבוה יותר מהתיאורטי
- בקורסים קליניים יש קושי במתן ציונים מכיוון שנחשבים סובייקטיביים.

הסיבות לאתגר הקשור במתן ציון נכשל בקורסים קליניים

- חששות לגבי השלכות הכשלת סטודנט
- לא מספיק זמן לתצפת על סטודנטים בשטח
- אמפתיה כלפי הסטודנטים
- השפעה כלכלית של הסטודנטים שיצטרכו לשלם שוב על הקורס החוזר

דרכי התמודדות עם אתגר זה

- מתן **הגדרות ברורות ומדייקות** של הסטנדרטים המקובלים להערכה והדרכת הסטודנטים בתחילת ההתנסות
- בטיחות המטופל הוא עיקרון מפתח ונמחה בתהליך אומדן ביצועי סטודנט – יש להגדיר הגדרות שעוסקות **בבטיחות הטיפול**
- **שותף קליני תומך** שמקשיב לחששות המדריך, משוחח עם הסטודנט ועורכים שיחות מעקב עם המדריך על מנת להעריך את הסטודנט בצורה הטובה ביותר.

מתן ציון לביצועים קליניים

- **הגדרה** – תהליך בו סגל ההוראה הקליני אומדן את ביצועי הסטודנט במסגרת הקלינית ולאחר מכן נותן לו ציון שקובע אם הסטודנט השיג את יעדי הקורס ונותן טיפול בטיחותי.

מתן ציון כולל בתוכו התייחסות ל:

- מתן טיפול בטיחותי
- ניתוח המצבים הטיפולים המורכבים
- פתרון בעיות
- תקשורת יעילה עם המטופל והצוותים הנוספים.

ציון עובר / נכשל מול ציון מספרי

סוג ציון	יתרונות	חסרונות
עובר / נכשל	- מעודדת רפלקציה והערכה עצמית - מאפשרת סביבה לימודית פחות תחרותית - אחדות קבוצתית חזקה - מאפשרת שיתוף פעולה בין הסטודנטים - מאפשרת פחות סטרס בקרב הסטודנטים	- אינו מייצג את מאמץ הסטודנטים בעלי השאיפות הגבוהות
ציון מספרי	- נותן עדות עבור הסטודנט והמדריך לגבי הרמה הלימודית ומצביע על דברים לשיפור	- הציונים ניתנים בקלות ויכולים לגרום לאינפלציה של ציונים.

הערכה עצמית

- **הגדרה** – תהליך בו היחיד בוחן את עצמו בצורה אובייקטיבית. חלק אינטגרלי בפיתוח עצמי, אומדן ורפלקציה עצמית וטיפול עצמי.

דברים חשובים בהערכה עצמית

- יש לבצע לפני ביצוע דיונים עם מנהלים
- רפלקציה מאפשרת לאמוד את העצמי, לזהות את ההצלחות והזדמנויות לשיפור.
- תהליך מתמשך ומתמיד שלא תלוי בהערכה השנתית.
- יש לקחת בחשבון גורמים חיצוניים ופנימיים כמו האקלים הלימודי, אמינות תהליך איסוף הנתונים, תכונות אישיות וקשרים עם אחרים.
- יש לספק משוב ספציפי, מתוזמן ובונה בסביבה בטוחה על ידי מדריכים מיומנים ואמינים.

הערכה עצמית ממוקדת תהליכים

- מתייחסת לתוכן ההערכה העצמית

- רפלקציה על גורמים שערכו או אפשרו השגת יעדים
- כולל סגנונות מנהיגות, קשרים בין אישיים, ניהול זמן או אחדות קבוצתית.
- מועצמת על ידי קבלת משוב מהאחר.

הערכה עצמית ממוקדת תוצאות

- מתייחסת לתוצרים כמו השלמת עבודות או הישגים.
- יכולה לפעמים להיות ביקורתית יתר על המידה – ניתן להשתמש במשוב ורפלקציה מהקבוצה שיעזור לסטודנט ללמוד מעמיתיו ולהביט על העצמי בכנות וחמלה.

מדידה של הערכה עצמית

כלים למדידה

- **הקלטות ביצועי הסטודנט** – מאפשר ביצוע הערכה עצמית בעזרת כלי מובנה.
- **NURSE COMPETENCE SCALE (NCS)** – כלי בו מודדים את כשירות הסטודנטים בתחומי ההתערבויות הטיפוליות והבטחת איכות.
- **שיתוף הסטודנט בחוזקות וחולשות שלו** – מאפשר לזהות את צרכי הסטודנט.

תיקון

הגדרה – תהליך או התנהגות לתקן טעויות או להשלים חסרים.

תיקון בלימודי הסיעוד – תהליך דרכו עושים חזרות ומחזקים חומר שנלמד במהלך ההדרכה, במטרה לשפר הבנה ויישום מעשי של הידע.

דרכים לתיקון דידיקטי בלימודי הסיעוד

- חזרה על חומר ההרצאה
- שיעור חזרה בסגנון שאלות ותשובות
- תרגול מבחנים לדוגמה
- הצגה בעל פה בפני חברי הכיתה
- הגשת מטלות כתובות

דרכים לתיקון מעשי בלימודי הסיעוד

- סימולציות – מאפשרות תרגול בטוח עד לשליטה טכנית במיומנות.
- השגה בשטח – ביצוע מיומנות תוך הנחייה ותיקון של המדריך או חבר לימודים.

תוכניות תיקון מותאמות – תפקיד המדריך

- יש צורך לבקש מהסטודנט לזהות את היתרונות והחסרונות של עצמו ולפתח תוכנית תיקון עבורו
- ההשפעה של רמת ביטחון עצמי נמוכה יכולה להקשות על תוכנית התיקון – יש לספק הנחייה ומוטיבציה עבור הסטודנטים הסובלים מדימוי עצמי וביטחון עצמי ירוד.
- יש לעודד את הסטודנטים לקחת אחריות ללמידה בכדי לעמוד במטרות הלימודיות

סטודנט מסוכן

הגדרה – סטודנט שאינו מסוגל לשמור על בטיחות הטיפול באופן שעומד בציפיות הלימודיות ובסטנדרטים המקצועיים.

- נוכחות של אחד או שילוב של מאפיינים פיזיים, רגשיים, קוגניטיביים, חברתיים, או אתיים מסכנים הגורמים לסטודנט להיות חשוף לטיפול לא בטיחותי.

תפקיד המדריך

- להפעיל שיקול דעת בבחירת הזדמנויות לימודיות מתאימות שיקדמו את התפתחות הסטודנטים מבלי לסכן את הציבור.
- להשתמש באסטרטגיות לימודיות מבוססת מחקר.
- להיות ערים לסיכונים
- לזהות סטודנטים ומצבים מסוכנים ולהרחיקם
- לאפשר ולתקן.
- לבצע דיאלוג מכון בין המדריך לסטודנטים לגבי בטיחות הטיפול בתחילת ההתנסות.

- לאפשר שותפות ללמידה המתאפיינת בהדדיות, אמון, ותקשורת פתוחה. השותפות מאפשרת לסטודנטים לבצע אינטגרציה של משוב בונה ומעצב שתומך במתן טיפול בטיחותי.

הנקודות המרכזיות המשותפות לתוכנית הלימוד המקדמות את נושא הבטיחות

- ידע מבוסס ראיות
- החולה במרכז
- הבהרת תפקידים ואחריות
- פיתוח היגיון קליני
- אינפורמטיקה של בריאות
- תיאוריות בתקשורת, מערכות וניהול סיכונים.

מאפייני סטודנט מסוכן מנקודת מבט של הסטודנטים

- כשלים בלקיחת אחריות מקצועית
- היעדר חשיבה ביקורתית
- גישה בה המטופל לא במרכז
- אינטראקציות בלתי יעילות.
- ביצועים קליניים לא מספקים
- התנהלות קלינית שאינה מבוססת ראיות.

שיטות להפחתת תופעת הסטודנטים המסוכנים

- למידה דרך בעיות – מצמצמת את הפער בין התיאוריה לקליניקה ומקדמת את נושא הבטיחות
- סימלוציות – מאפשרת למדריך להעריך את הסטודנט עם אפשרות למתן משוב מיידי. מאפשר לסטודנט לבצע רפלקציה ולעדן או לתקן את הביצועים לפני מגע עם מטופל.
- תקשורת לגבי בטיחות הטיפול שעונה על צרכי הסטודנטים
- זיהוי הסיכונים הפוטנציאליים של מתן טיפול לא בטיחותי